

Datei: eml/01_akteneinsicht_drv_anforderung.eml

Von	Marit Sonnemann <kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de>
An	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland <poststelle@drv-mitteldeutschland.de>
Datum	Wed, 18 Feb 2026 10:34:17 +0100
Betreff	Akteneinsicht - Az. xx 060379 41 W 077 - Feldermann, Vivian - DRINGEND

Sehr geehrte Damen und Herren der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland,

ich zeige an, dass ich Frau Vivian Feldermann, geb. 03.09.1984,
Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig, anwaltlich vertrete.

Eine Vollmacht liegt diesem Schreiben in Kopie bei.

Ich beantrage hiermit gemäß Paragraf 25 SGB X Akteneinsicht in die vollständige
Verwaltungsakte, Aktenzeichen xx 060379 41 W 077, einschließlich:

- des vollständigen ärztlichen Gutachtens Dr. Härtung
(Sozialmedizin, November 2025)
- aller internen medizinischen Stellungnahmen des ärztlichen Dienstes der DRV
- des vollständigen Versicherungsverlaufs
- der gesamten Korrespondenz seit Antragstellung (Januar 2024)

Ich bitte um Einsichtnahmemöglichkeit in den Räumlichkeiten der DRV Leipzig
(Georg-Schumann-Str. 146) bis spätestens 04.03.2026, da die
Widerspruchsfrist am 14.03.2026 endet.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Sozialrecht

Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Karl-Liebknecht-Straße 14

04107 Leipzig

Tel.: 0341 / 58 82 100

Fax: 0341 / 58 82 101

kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de

Anlage: Vollmacht Vivian Feldermann (PDF)

Datei: eml/02_akteneinsicht_drv_bestatigung.eml

Von	DRV Mitteldeutschland <thomas.vogel@drv-mitteldeutschland.de>
An	Kanzlei Sonnemann <kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de>
Datum	Fri, 20 Feb 2026 14:12:43 +0100
Betreff	AW: Akteneinsicht - Az. xx 060379 41 W 077 - Feldermann, Vivian

Sehr geehrte Frau Sonnemann,

Ihren Antrag auf Akteneinsicht vom 18.02.2026 haben wir erhalten.
Wir bestätigen die Vollmacht von Frau Feldermann und werden die Akte zur Einsichtnahme vorbereiten.

Ein Termin zur Akteneinsicht kann am

04. März 2026 um 10:00 Uhr

bei uns stattfinden (Georg-Schumann-Straße 146, Leipzig, Zimmer 214,
2. OG, Abteilung Erwerbsminderungsrente).

Bitte bringen Sie zur Einsichtnahme einen Lichtbildausweis mit.

Wir weisen darauf hin, dass Ablichtungen der Akte gegen eine
Kostenerstattung von 0,10 EUR je Kopie angefertigt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Vogel
Sachbearbeiter
Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
Abteilung Erwerbsminderungsrente
Georg-Schumann-Straße 146, 04155 Leipzig
Tel.: 0800 / 10 00 48 00 (kostenfrei)

Datei: eml/03_mandantin_jobcenter_schweigen.eml

Von	Vivian Feldermann <vivian.feldermann@gmx.de>
An	Kanzlei Sonnemann <kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de>
Datum	Tue, 10 Mar 2026 09:22:11 +0100
Betreff	Jobcenter meldet sich nicht - Vermieter droht wieder

Sehr geehrte Frau Sonnemann,

ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in die Woche.

Ich mache mir sehr große Sorgen. Das Jobcenter hat auf unseren Widerspruch vom November 2025 noch immer nicht geantwortet. Dabei sind jetzt fast vier Monate vergangen.

Außerdem hat unser Vermieter, Herr Günther, heute wieder angerufen. Er hat gesagt, wenn bis Ende März keine vollständige Mietzahlung erfolgt, schaltet er seinen Anwalt ein. Ich habe Angst, dass wir die Wohnung verlieren. Liam und Marlene wissen noch nichts davon, aber Marko und ich machen uns täglich Sorgen.

Ich konnte heute nach dem Anruf nicht mehr aufstehen – der Stress löst sofort einen Crash aus.

Was soll ich tun? Können wir dem Jobcenter irgendwie Druck machen?

Mit freundlichen Grüßen
Vivian Feldermann

PS: Ich schicke Ihnen morgen die neuesten Lohnabrechnungen von Marko (Januar und Februar 2026) per Post.

Von	Marit Sonnemann <kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de>
An	Vivian Feldermann <vivian.feldermann@gmx.de>
Datum	Tue, 10 Mar 2026 11:47:35 +0100
Betreff	AW: Jobcenter meldet sich nicht - Vermieter droht wieder

Liebe Frau Feldermann,

Ihre Sorge ist nachvollziehbar. Die nächsten Schritte laufen bereits.

Zum Eilantrag beim Sozialgericht Leipzig (Az. S 7 AS 188/26 ER):
Das Sozialgericht hat für Donnerstag, den 12.03.2026, einen
Erörterungstermin anberaumt. Ich werde dort persönlich auftreten und
unsere Argumente vortragen. Erfahrungsgemäß entscheidet das SG Leipzig
in solchen Eilverfahren sehr zügig – ich erwarte die Entscheidung noch
diese Woche oder Anfang nächster Woche.

Bitte teilen Sie Herrn Günther formlos mit (WhatsApp oder kurze E-Mail
genügt), dass ein Gerichtsverfahren läuft und Sie in wenigen Tagen mit
einer richterlichen Entscheidung rechnen. Damit ist der Sachstand
dokumentiert; eine Kündigung wird dadurch allerdings nicht ausgeschlossen.

Zum Jobcenter-Widerspruch:
Die gesetzliche Frist für eine Widerspruchsentscheidung beträgt 3 Monate.
Diese Frist lief am 14. Februar 2026 ab (Widerspruch November 2025 –
3 Monate). Ich werde beim Jobcenter schriftlich eine Entscheidung anmahnen.
Falls bis Ende März kein Widerspruchsbescheid vorliegt, erheben wir
Untätigkeitsklage (Paragraf 88 SGG) – das ist ein zusätzliches Druckmittel.

Zum Crash nach dem Vermieter-Anruf:
Bitte dokumentieren Sie das in Ihrem PEM-Tagebuch: Auslöser "Telefonat,
emotionaler Stress, ca. 10 Minuten" → Crash. Das ist wichtig für alle
Verfahren, die Ihre Leistungsunfähigkeit belegen müssen.

Bitte ruhen Sie sich heute aus. Die Lohnabrechnungen von Marko können
gern auch eingescannt per E-Mail kommen – das schont Ihre Energie.

Ich melde mich sofort nach dem SG-Termin am Donnerstag.

Herzliche Grüße und gute Besserung,

Marit Sonnemann
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Sozialrecht
Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig
Karl-Liebknecht-Straße 14, 04107 Leipzig
Tel.: 0341 / 58 82 100 | kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de

Von	Marit Sonnemann <kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de>
An	Bezirksverwaltung Leipzig <bv-leipzig@bgw-online.de>
Datum	Wed, 18 Feb 2026 11:05:18 +0100
Betreff	Akteneinsicht - BK 3101 / 261/26 - Feldermann, Vivian

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem bei Ihnen unter dem Aktenzeichen BK 3101 / 261/26 geführten Verfahren vertrete ich Frau Vivian Feldermann, geboren am 3. September 1984, Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig. Die unterzeichnete Vollmacht und eine Kopie des Bescheids vom 28. Januar 2026 sind beigefügt.

Ich beantrage nach Paragraph 25 SGB X Einsicht in die vollständige Verwaltungsakte. Die Einsicht soll insbesondere die Expositionsermittlung, Dienst- und Belegungspläne, Unterlagen zur Ausgabe persönlicher Schutzausrüstung, Befragungsniederschriften, medizinische Stellungnahmen, internen Entscheidungsvorlagen sowie das vollständige Eingangs- und Ausgangsverzeichnis umfassen.

Wegen der laufenden Widerspruchsfrist bitte ich um einen Termin bis spätestens 5. März 2026. Für den Fall, dass einzelne Aktenteile nicht vorgelegt werden sollen, bitte ich um eine konkrete Bezeichnung des Aktenstücks, der Blattzahl und der hierfür herangezogenen gesetzlichen Grundlage.

Als Termine kann ich den 3. März ab 13:00 Uhr oder den 5. März zwischen 08:30 und 12:00 Uhr wahrnehmen. Bitte bestätigen Sie auch, ob eigene Scans angefertigt werden dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Sozialrecht
Kanzlei Sonnemann Sozialrecht
Karl-Liebknecht-Straße 14, 04107 Leipzig
Telefon 0341 2647-310

Anlagen:

1. Vollmacht Vivian Feldermann vom 17. Februar 2026
2. Bescheid der BGW vom 28. Januar 2026

Datei: eml/06_akteneinsicht_bgw_bestaetigung.eml

Von	Claudia Reimers <claudia.reimers@bgw-online.de>
An	Marit Sonnemann <kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de>
Datum	Sat, 21 Feb 2026 09:47:26 +0100
Betreff	AW: Akteneinsicht - BK 3101 / 261/26 - Feldermann, Vivian

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Sonnemann,

Ihren Antrag auf Akteneinsicht und die Vollmacht haben wir am 18. Februar 2026 erhalten.

Die Akte kann am Donnerstag, 5. März 2026, ab 09:00 Uhr in unserer Bezirksverwaltung Leipzig, Torgauer Platz 3, Besprechungsraum 2.14, eingesehen werden. Bitte melden Sie sich am Empfang und bringen Sie einen Lichtbildausweis mit. Für den Termin ist Frau Claudia Reimers, Durchwahl 214, zuständig.

Sie dürfen mit einem eigenen mobilen Gerät Ablichtungen fertigen, soweit dadurch der Dienstbetrieb nicht beeinträchtigt wird. Die Akte umfasst derzeit 286 Blatt und einen gesonderten medizinischen Umschlag. Vor dem Termin wird geprüft, ob einzelne interne Entwürfe oder Daten Dritter nur teilweise zugänglich gemacht werden können. Sollte dies der Fall sein, erhalten Sie hierzu am Termin eine schriftliche Aufstellung mit Blattzahlen und Begründung.

Bitte bestätigen Sie den Termin bis zum 24. Februar 2026. Falls Sie mehr als zwei Stunden benötigen, teilen Sie dies kurz mit.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Reimers
Sachbearbeiterin Berufskrankheiten
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
Bezirksverwaltung Leipzig
Torgauer Platz 3, 04315 Leipzig
Telefon 0341 9928-214

Datei: eml/07_mandantin_bgw_eingang_und_unterlagen.eml

Von	Vivian Feldermann <vivian.feldermann@gmx.de>
An	Marit Sonnemann <kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de>
Datum	Sat, 28 Feb 2026 10:18:42 +0100
Betreff	BGW-Eingang bestätigt und Unterlagen für die Akte

Sehr geehrte Frau Sonnemann,

heute lag die Eingangsbestätigung der BGW im Briefkasten. Darin steht, dass mein Widerspruch vom 26. Februar eingegangen ist und nach der Akteneinsicht weiter bearbeitet wird. Ich habe das Schreiben als Scan beigefügt. Muss ich selbst noch etwas unterschreiben oder hinschicken?

Außerdem habe ich die Unterlagen für das Jobcenter zusammengestellt: den Mietvertrag, die Lohnabrechnung von Marko für Dezember 2025 und das Schreiben unseres Vermieters vom 28. Januar. Die Originale möchte ich nicht verlieren. Reichen vorerst gut lesbare Scans oder soll ich Kopien per Einschreiben schicken?

Seit dem Termin am Dienstag bin ich wieder deutlich erschöpfter. Deshalb würde ich die Unterlagen gern digital senden, wenn das ausreicht.

Mit freundlichen Grüßen

Vivian Feldermann
Bornaische Straße 78
04277 Leipzig

Anlagen:

1. BGW_Eingang_Widerspruch_27-02-2026.pdf
2. Mietvertrag_Auszug.pdf
3. Lohnabrechnung_Marko_12-2025.pdf
4. Vermieterschreiben_28-01-2026.pdf

Datei: eml/08_kanzlei_antwort_bgw_eingang.eml

Von	Marit Sonnemann <kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de>
An	Vivian Feldermann <vivian.feldermann@gmx.de>
Datum	Sun, 01 Mar 2026 09:06:14 +0100
Betreff	AW: BGW-Eingang bestätigt und Unterlagen für die Akte

Liebe Frau Feldermann,

die Eingangsbestätigung ist angekommen und der dort genannte Eingang am 26. Februar stimmt mit unserem Faxprotokoll überein. Von Ihnen ist hierzu derzeit keine weitere Unterschrift erforderlich. Ich nehme das Schreiben und den Umschlag getrennt zur Akte.

Die vier Scans sind lesbar. Bitte behalten Sie die Originale zunächst bei sich und notieren Sie auf dem Umschlag das tatsächliche Eingangsdatum. Falls eine Behörde ein Original verlangt oder die Echtheit bestreitet, stimmen wir die Vorlage gesondert ab. Ein zusätzliches Einschreiben ist im Moment nicht nötig.

Am 5. März sehe ich die BGW-Akte ein. Danach erhalten Sie eine kurze Nachricht dazu, welche Unterlagen dort tatsächlich vorhanden sind und welche Angaben wir für die Widerspruchsbegründung noch benötigen. Bitte schonen Sie bis dahin Ihre Kräfte; neue Unterlagen können gesammelt in einer Nachricht kommen.

Herzliche Grüße

Marit Sonnemann
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Sozialrecht
Kanzlei Sonnemann Sozialrecht
Karl-Liebknecht-Straße 14, 04107 Leipzig
Telefon 0341 2647-310

Tabellenblatt: Bedarfsberechnung Vergleich

Bedarfs- und Einkommensberechnung SGB II – Bedarfsgemeinschaft Feldermann

Stand: Februar 2026 | Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig | Az. BG-L-2025-88-44123

A) BEDARF DER BEDARFSGEMEINSCHAFT (Paragrafen 20, 21, 22 SGB II)

Position

Person / Grundlage

Jobcenter-Ansatz (EUR/Mon.)

Kanzlei-Ansatz (EUR/Mon.)

Diff. (EUR)

Anmerkung

Regelbedarf Frau Feldermann

SB 1 (Paragraf 20 Abs. 2 Nr. 1 SGB II, 2026)

563

563

Regelbedarf Herr Feldermann

SB 2 (Paragraf 20 Abs. 2 Nr. 1 SGB II, 2026)

563

563

Regelbedarf Liam (11 J.)

SB 4 (Paragraf 23 Nr. 1 SGB II, 6.–13. LJ: 390 EUR)

348

390

JC hat falschen Regelbedarf angesetzt

Regelbedarf Marlene (8 J.)

SB 5 (Paragraf 23 Nr. 2 SGB II, 14.–17. LJ: 390)

390

390

Mehrbedarf Paragraf 21 Abs. 4 SGB II
Krankheitsbedingte Mehraufwend. (ME/CFS)
0
80
JC abgelehnt, streitig

KdU – Kaltmiete (Paragraf 22 SGB II)
Bornaische Str. 78, 80 m², Connewitz
780
960
JC-Richtlinie vs. Mietpreisspiegel 2024

Heizkosten (Paragraf 22 Abs. 1 SGB II)
tatsächlich
185
185

GESAMTBEDARF

B) EINKOMMENANRECHNUNG (Paragrafen 11, 11a, 11b SGB II) – Marko Feldermann

Position
Grundlage
Jobcenter-Ansatz (EUR)
Kanzlei-Ansatz (EUR)
Diff. (EUR)
Anmerkung

Bruttoeinkommen
Lohnabrechnung 12/2025
4310
4310

./ Lohnsteuer

tatsächlich (Lohnabr.)

-919.5

-608

JC hat pauschal berechnet

./ SV-Beiträge

AN-Anteil KV+RV+AV+PV

0

-819

In JC-Berechnung nicht separat

Netto nach Steuern/SV

3390.5

2883

./ Erwerbstätigenpauschale

Paragraf 11b Abs. 2 SGB II

-100

-100

./ Fahrtkosten Arbeitsweg

70 km/Tag × 0,20 EUR × 20 AT

-30

-280

JC nur Pauschale 30 EUR

./ Kinderbetreuungskosten

Hort Marlene, Eigenanteil

0

-100

JC nicht berücksichtigt

./.. Krankheitskosten
Apotheke, Zuzahlungen
0
0
Wird separat geprüft

Anrechenbares Netto
Paragraf 11 Abs. 1 SGB II
3260.5
2403
Differenz: 857,50 EUR

C) ERGEBNIS: UNGEDECKTER BEDARF / ANSPRUCH SGB II

Gesamtbedarf
JC-Berechnung

./.. Anrechenbares Einkommen

Ungedeckter Bedarf (SGB-II-Anspruch)
JC: kein Anspruch

Hinweis: JC-Ansatz = Berechnung Jobcenter Leipzig laut Bescheid 14.11.2025. Kanzlei-Ansatz = korrigierte Berechnung RA Sonnemann (tatsächliche Absetzbeträge gem. Paragraf 11b SGB II). Differenz zeigt nachweisbaren SGB-II-Anspruch von ca. 426 EUR/Mon. + KdU-Differenz 180 EUR = ca. 606 EUR/Mon.

Tabellenblatt: KdU-Angemessenheit Leipzig

KdU-Angemessenheitsvergleich Leipzig 2024–2026 (4-Personen-Haushalt)

Quelle: Mietpreisspiegel Leipzig 2024 | JC-Richtlinie 2023 | Wohngeldgesetz-Anlage 2024

Datenquelle

EUR/m² (Kaltmiete)

Ansatz 80 m² (EUR)

Basis

Einordnung

Jobcenter-Richtlinie 2023

9.75

780

Pauschal, ohne schlüssiges Konzept

Zu niedrig (BSG-Rspr.)

Mietpreisspiegel Leipzig 2024 (Connewitz, untere Schwelle)

10.8

864

Amtlicher Mietspiegel

Mindestmarkt

Mietpreisspiegel Leipzig 2024 (Connewitz, Median)

12

960

Amtlicher Mietspiegel

Tatsächliche Miete

Mietpreisspiegel Leipzig 2024 (Connewitz, obere Schwelle)

14.2

1136

Amtlicher Mietspiegel

Oberes Segment

Wohngeldtabelle 2024, Stufe IV Leipzig (4 Pers.)

11.5

920

Paragraf 12 WoGG

Vergleichswert

Vermieter-Angebot (tatsächliche Kaltmiete)

12

960

Mietvertrag

Marktkonform

Fazit: Die tatsächliche Kaltmiete (960 EUR = 12,00 EUR/m²) liegt im Bereich des Medians des Mietpreisspiegels Leipzig 2024 für Connewitz und ist damit marktkonform und angemessen im Sinne des Paragraphen 22 Abs. 1 SGB II. Die Jobcenter-Richtlinie (780 EUR) liegt unter der unteren Mietpreisspiegel-Schwelle und erfüllt nicht die Anforderungen des BSG an ein 'schlüssiges Konzept' (BSG, Urt. v. 22.09.2009 – B 4 AS 18/09 R).

Tabellenblatt: Monatsübersicht

PEM-Score – Belastungs- und Aktivitätsübersicht

Mandantin: Vivian Feldermann | Erstellt auf Basis PEM-Tagebuch (Aug 2025 – Jan 2026)

Monat

Bettlägerig-Tage

Ges.-Tage

Bettlägerig %

Crash-Episoden

Ø Aktiv-Fenster (min)

Min Aktiv

Max Aktiv

Auslöser (Hauptkategorie)

Aug 2025

17

31

5

12

0

40

Arzttermin, Spaziergang, Telefonat

Sep 2025

16

30

4

14

0

35

SKH-Aufnahme, Dusche, Behörde

Okt 2025

18

31

6

10

0

30

Arzttermine, Kinder, Einkauf

Nov 2025

15

30

4

16

0

45

Sozialamtbesuch, Telefonate

Dez 2025

20

31

7

8

0

25

Weihnachtsbelastung, Formulare

Jan 2026

21

31

8

7

0

20

Bescheide, Kanzleitermin 17.02.

Gesamt 6 Monate

Erläuterung: 'Bettlägerig-Tage' = Energiepegel ≤ 1 (vollst. bettlägerig/ans Sofa gebunden). 'Crash' = Post-Exertional Malaise-Episode nach Aktivität (Dauer 1–7 Tage). 'Ø Aktiv-Fenster' = durchschnittliche tägliche Zeitspanne, in der Aktivität ohne sofortigen Crash möglich. Quelle: PEM-Tagebuch Vivian Feldermann (Eigenaufzeichnung), ausgewertet für Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig.

Tabellenblatt: Tagesprotokoll Aug 2025

Tagesprotokoll August 2025 – Vivian Feldermann (PEM-Tagebuch)

Datum

Energiepegel (0–10)

Aktiv-Fenster (min)

Crash (J/N)

Crash-Intensität

Crash-Dauer (Tage)

Hauptsymptome

Anmerkung

01.08.2025

3

20

N

0

Fatigue, Kopfschmerzen, brain fog

02.08.2025

2

10

N

0

Starke Erschöpfung, Schwindel

03.08.2025

1

0

J

mittel

3

Bettlägerig, Toilettengang → Crash

04.08.2025

1

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig

Crash-Tag 2

05.08.2025

1

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig, Schmerzen

Crash-Tag 3

06.08.2025

2

15

N

0

Etwas besser, kurzes Sitzen

07.08.2025

3

25

N

0

Fatigue, kein Lesen möglich

08.08.2025

3

30

N

0

Guter Tag

09.08.2025

4

40

J

leicht

1

Herd aufgeräumt → Crash

10.08.2025

2

10

J

anhalt.

0

Schlechter nach gestern

Crash-Tag 2

11.08.2025

2

15

N

0

Besserung

12.08.2025

1

0

J

schwer

4

Arzttermin → Crash (Fahrt, Warten)

13.08.2025

1

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig

Crash-Tag 2

14.08.2025

1

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig

Crash-Tag 3

15.08.2025

1

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig, Fieber 37,9°C

Crash-Tag 4

16.08.2025

2

10

N

0

Erste Besserung

17.08.2025

3

20

N

0

Fatigue

18.08.2025

2

15

N

0

Schlecht geschlafen

19.08.2025

3

25

N

0

Mittel

20.08.2025

4

35

J

mittel

2

Spaziergang 100m → Crash

21.08.2025

2

10

J

anhalt.

0

Crash nach Spaziergang gestern

22.08.2025

2

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig

23.08.2025

2

15

N

0

Etwas besser

24.08.2025

3

20

N

0

Fatigue, brain fog

25.08.2025

2

10

N

0

Müde

26.08.2025

1

0

J

schwer

5

Telefonat 40 min → Crash

27.08.2025

1

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig

Crash-Tag 2

28.08.2025

1

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig

Crash-Tag 3

29.08.2025

1

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig

Crash-Tag 4

30.08.2025

1

0

J

anhalt.

0

Bettlägerig, Schmerzen 7/10

Crash-Tag 5

31.08.2025

2

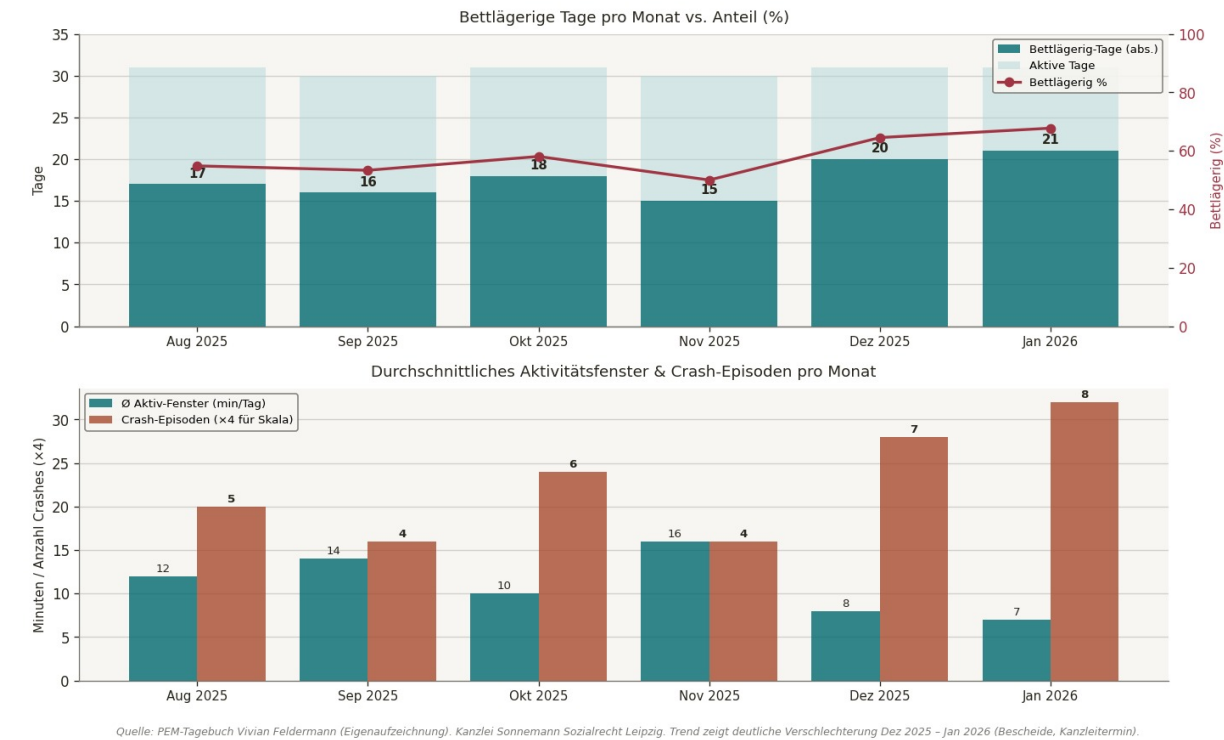
10

N

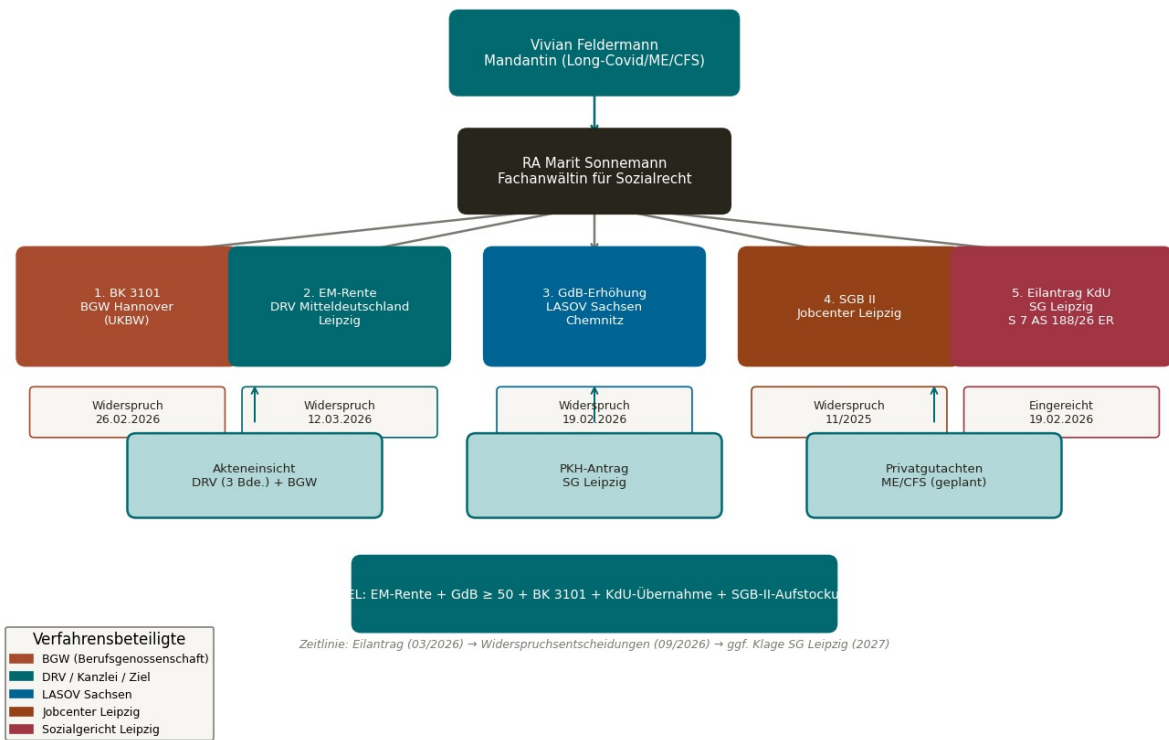
0

Leichte Besserung

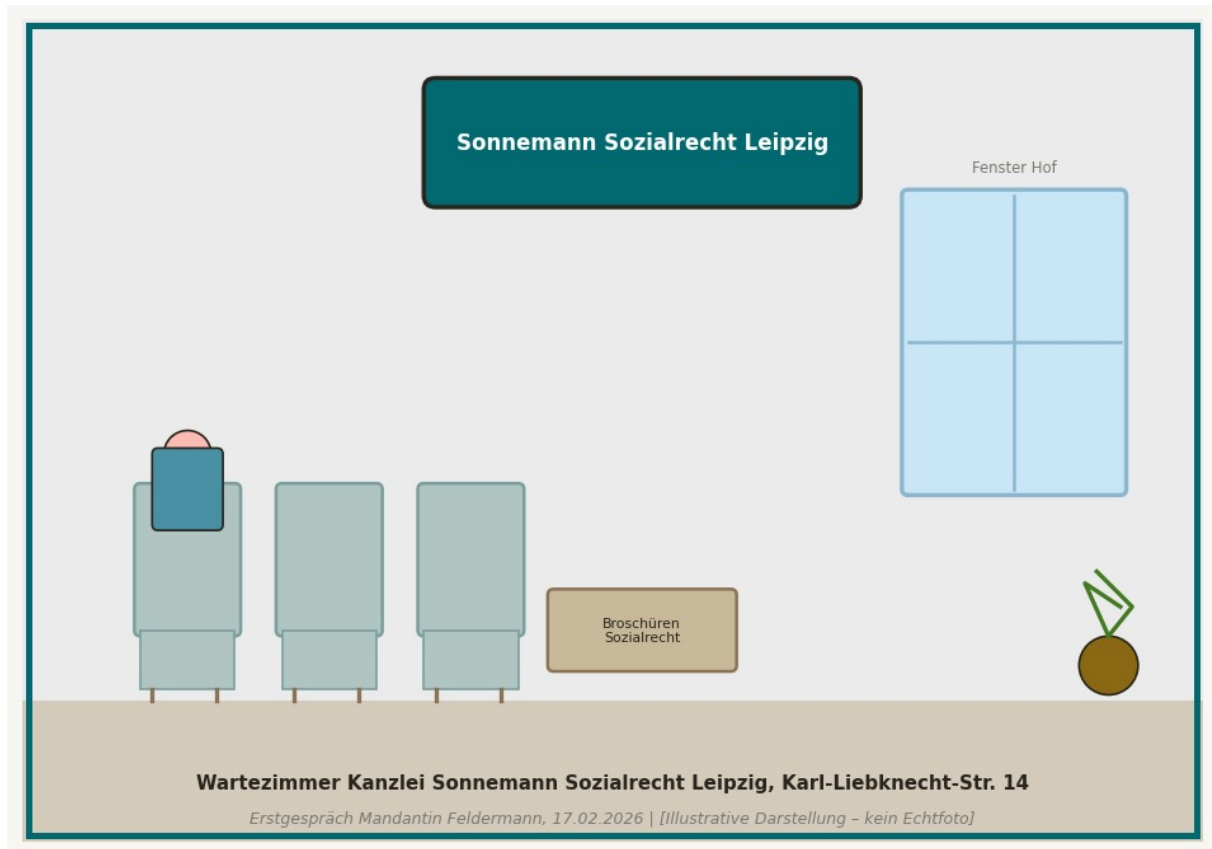
PEM-Aktivitätsdiagramm - Vivian Feldermann (Aug 2025 - Jan 2026)



Organigramm Verfahren - Akte Feldermann (Stand März 2026)



Datei: jpg/03_kanzleibesuch_wartebereich_illustration.jpg



Bilddatei: 03_kanzleibesuch_wartebereich_illustration.jpg

Datei

Office-Dokument: 01_aktenvorblatt_sonnemann.docx

Aktenvorblatt – Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Kanzlei: Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Anwältin: Rechtsanwältin Marit Sonnemann, Fachanwältin für Sozialrecht

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 14, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 58 82 100

Fax: 0341 / 58 82 101

E-Mail: kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de

Aktenzeichen Kanzlei

Internes AZ: SON-2026-0047-FEL

Angelegt: 17.02.2026

Sachbearbeiterin: RA Sonnemann / Frau Krüger (Sekretariat)

Mandantin

Feld	Angabe
Name	Vivian Feldermann, geb. Hartmann
Geburtsdatum	03.09.1984 (41 Jahre)
Adresse	Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig (Connewitz)
Telefon	0341 / 9 34 77 21 (privat), 0176 / 44 83 92 55 (mobil)
E-Mail	vivian.feldermann@gmx.de
Beruf	Krankenschwester (Gesundheits- und Krankenpflegerin), derzeit vollständig arbeitsunfähig
Familienstand	verheiratet
Kinder	Liam Feldermann (geb. 14.03.2014, 11 J.), Marlene Feldermann (geb. 08.11.2016, 8 J.)

Ehemann: Marko Feldermann, geb. 18.11.1981

Beruf: Industriemeister Maschinenbau, Linde Sächsisch GmbH, Leipzig

Brutto-Einkommen: 4.310,00 EUR / Monat

Verfahrensübersicht

Nr.	Verfahren	Behörde / Gericht	Ext. AZ	Status
1	BK 3101-Anerkennung	BGW Hannover (BGW)	BK 3101 / 261/26	Widerspruch eingelegt
2	Erwerbsminderung srente	DRV Mitteldeutschland Leipzig	xx 060379 41 W 077	Widerspruch eingelegt
3	GdB-Festsetzung	LASOV Sachsen,	—	Widerspruch

		Referat 23		vorbereitet
4	SGB-II Leistungen	Jobcenter Leipzig	—	Widerspruch eingelegt
5	Eilantrag KdU	SG Leipzig	S 7 AS 188/26 ER	eingereicht 19.02.2026
6	Akteneinsicht DRV	DRV Mitteldeutschland	xx 060379 41 W 077	angefordert 18.02.2026
7	Akteneinsicht BGW	BGW Hannover	BK 3101 / 261/26	angefordert 18.02.2026

Fristen (kritisch)

Frist	Datum	Verfahren
Widerspruch BK 3101	28.02.2026	BGW Hannover
Widerspruch EM-Rente	14.03.2026	DRV Mitteldeutschland
Widerspruch GdB	15.03.2026	LASOV Sachsen
Widerspruch SGB-II	28.02.2026	Jobcenter Leipzig
Anhörung SG Eilantrag	nach Eingang	SG Leipzig

Finanzierung / PKH

Prozesskostenhilfe-Antrag vorbereitet (vgl. Aktenstück 21).

Klärungsbedarf: Anrechnung Einkommen Ehemann bei PKH-Prüfung (Paragraf 115 ZPO i. V. m. Paragraf 73a SGG).

Notizen Aktenführung

- Alle Originalunterlagen liegen als Scans im digitalen Mandantenordner vor.
- PEM-Tagebuch (Original) bei Mandantin verwahrt; Auszug in Akte (Aktenstück 17).
- Ärztliche Befunde: Hausarzt Dr. Märker (Leipzig), Post-COVID-Ambulanz der Universitätsmedizin Berlin-Nord (Prof. Seifert, Berlin), SKH Psychiatrie Leipzig.
- Nächster Besprechungstermin: 05.03.2026, 10:00 Uhr, Kanzlei.

Angelegt: 17.02.2026 – RA Sonnemann

Datei

Office-Dokument: 02_kanzleinotiz_erstgesprach_feldermann.docx

Kanzleinotiz – Erstgespräch Mandantin Feldermann

Datum: 17.02.2026, 14:30–16:45 Uhr

Ort: Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 14

Anwesend: RA Marit Sonnemann; Vivian Feldermann (Mandantin); Marko Feldermann (Ehemann, nach ausdrücklicher Bitte der Mandantin anwesend)

Protokoll: Frau Krüger (Kanzleisekretariat), stichpunktartig

1. Anlass und Kontaktaufnahme

Frau Feldermann meldete sich am 12.02.2026 telefonisch in der Kanzlei, nachdem sie durch den Patientenverband Long Covid Deutschland auf RA Sonnemann aufmerksam geworden war. Anlass war der Erhalt des Ablehnungsbescheids der DRV Mitteldeutschland vom 14.02.2026 (Erwerbsminderungsrente) sowie die unmittelbar drohende Wohnungskündigung durch den Vermieter in Connewitz infolge der KdU-Kürzung durch das Jobcenter Leipzig.

2. Schilderung der Mandantin (zusammengefasst)

Frau Feldermann ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeitete seit 2009 am Universitätsklinikum Leipzig (UKL), zuletzt auf der Station für Hämatologie und Onkologie (Innere Medizin). Im November 2021 erkrankte sie während einer Einsatzsituation auf der Covid-Isolierstation an einer schweren SARS-CoV-2-Infektion; nach eigenem Bericht fehlte damals adäquate Schutzausrüstung (kein FFP2-Masken-Pflichtprogramm). Seitdem ist sie dauerhaft arbeitsunfähig.

Beschwerden heute (Februar 2026):

- Post-Exertional Malaise (PEM): jede körperliche oder kognitive Anstrengung führt zum Crash mit mehrtägiger Bettruhe
- Schwere chronische Fatigue (Schlafqualität schlecht, tagsüber nicht erholsam)
- Kognitive Dysfunktion ("brain fog"): Wortfindungsstörungen, Konzentrations- und Gedächtnisdefizite
- Kardiale Dysautonomie, v. a. POTS (Posturales Tachykardie-Syndrom): Herzrasen beim Aufstehen, Schwindel, Ohnmachtsneigung
- Psychisch: depressive Episoden, behandelt durch Klinikum am Auenwald Leipzig (F33.1, mittelgradige depressive Episode, rezidivierend)

Die Mandantin kann nach eigener Aussage das Haus an schlechten Tagen (ca. 4–5 von 7 Wochentagen) nicht verlassen. An sog. "guten Tagen" ist sie maximal 1–2 Stunden aktiv, danach folgt zwingend Ruhephase. Haushaltsführung kaum möglich, Kinderbetreuung von Liam (11) und Marlene (8) weitgehend durch den Ehemann.

3. Bisherige Verfahrenschronologie (von Mandantin geschildert)

Datum	Vorgang
-------	---------

11/2021	SARS-CoV-2-Infektion (beruflich, Covid-Station UKL)
12/2021	Erste Krankschreibung; Beginn Symptomatik Post-Covid
03/2022	Erstvorstellung Post-COVID-Ambulanz der Universitätsmedizin Berlin-Nord (Berlin, Prof. Seifert)
07/2022	Diagnose POTS-Verdacht; Hausarzt Dr. Märker, Leipzig
11/2022	Antrag auf Anerkennung als Berufskrankheit (BK 3101) bei der BGW Hannover
02/2023	Antrag auf Festsetzung GdB beim LASOV Sachsen
09/2023	LASOV-Bescheid: GdB 30 (Mandantin erwartet mind. 50)
01/2024	Antrag Erwerbsminderungsrente bei DRV Mitteldeutschland
09/2025	Antrag SGB-II (aufstockende Leistungen) beim Jobcenter Leipzig
11/2025	Jobcenter lehnt SGB-II-Leistungen ab (zu hohes Ehemann-Einkommen); KdU-Kürzung
01/2026	Vermieter droht Räumungsklage an (schriftlich)
28.01.2026	BGW-Bescheid: BK 3101 abgelehnt
14.02.2026	DRV-Bescheid: EM-Rente abgelehnt

4. Vorgelegte Unterlagen (Originalübergabe an Kanzlei)

- ☐ Bescheid BGW vom 28.01.2026 (BK 3101)
- ☐ Bescheid DRV Mitteldeutschland vom 14.02.2026 (EM-Rente)
- ☐ Bescheid LASOV vom 09/2023 (GdB 30)
- ☐ Bescheid Jobcenter Leipzig vom 11/2025 (SGB-II-Ablehnung + KdU-Kürzung)
- ☐ Schreiben Vermieter (Räumungsdrohung)
- ☐ Befund Dr. Märker (Hausarzt), 01/2026
- ☐ Universitätsmedizin Berlin-Nord-Befundbericht, Prof. Seifert, 11/2025
- ☐ SKH-Entlassungsbericht Psychiatrie, 02/2026 (Reha-Empfehlung)
- ☐ Auszug PEM-Tagebuch (Mandantin selbst geführt, 6 Monate)
- ☐ Einkommensnachweis Ehemann (Lohnabrechnung Dezember 2025)
- ☐ Mietvertrag + Miethöhe Connewitz

5. Mandantenauftrag / Bevollmächtigung

Frau Feldermann erteilt hiermit Vollmacht an RA Sonnemann für:

1. Widerspruch BK 3101 gegen BGW-Bescheid vom 28.01.2026
2. Widerspruch Erwerbsminderungsrente gegen DRV-Bescheid vom 14.02.2026
3. Widerspruch GdB-Erhöhung gegen LASOV-Bescheid (Widerspruch war schon eingeleitet, Übernahme)
4. Widerspruch SGB-II gegen Jobcenter Leipzig
5. Eilantrag beim SG Leipzig (KdU-Kürzung / Wohnungsgefährdung)
6. Akteneinsicht DRV und BGW
7. Prozesskostenhilfverfahren (soweit erforderlich)

Vollmachtsurkunde gesondert unterzeichnet und zu den Akten genommen.

6. Offene Klärungspunkte

- Krankenkasse: AOK Plus Sachsen – liegt Krankenversicherungsschutz noch vor? Klären.
- Hat DRV ein Gutachten eingeholt? Falls ja, welches? → Akteneinsicht
- War die Schutzausstattung am UKL dokumentiert? → Ärztliche Zeugen, Betriebsrat UKL kontaktieren
- PKH-Prüfung: Einkommen Ehemann (4.310 EUR brutto) vs. Freibeträge → Berechnung erforderlich (Aktenstück 21)

7. Sofortmaßnahmen

8. **Eilantrag SG Leipzig** (KdU) – Einreichung bis 19.02.2026 (Rücksicht auf Vermieterandrohung)
9. **Akteneinsicht anfordern** – DRV und BGW (schriftlich, 18.02.2026)
10. **Widerspruch BGW** – Frist 28.02.2026
11. **Widerspruch DRV** – Frist 14.03.2026

Protokoll: Krüger / Gegenlesen: RA Sonnemann, 17.02.2026

Datei

Office-Dokument: 03_anamnese_chronologie_2021_2026.docx

Anamnese und Erkrankungschronologie – Vivian Feldermann (2021–2026)

Erstellt: 17.02.2026

Erstellt durch: RA Sonnemann nach Erstgespräch und Aktenlage

Zweck: Verfahrensübergreifende Sachverhaltsdarstellung; Grundlage für alle Schriftsätze

1. Zur Person

Vivian Feldermann, geb. 03.09.1984 in Halle/Saale, wohnhaft Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig-Connewitz, ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie absolvierte ihre Ausbildung 2003–2006 am Universitätsklinikum Halle und war von September 2009 bis November 2021 am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) tätig, zuletzt als Stationsschwester auf der hämatologisch-onkologischen Station (Station 10a, Innere Medizin). Sie ist verheiratet mit Marko Feldermann und Mutter zweier minderjähriger Kinder: Liam (geb. 2014) und Marlene (geb. 2016).

2. Berufliche Exposition – November 2021

Im Rahmen der vierten SARS-CoV-2-Welle (Oktober–Dezember 2021) wurde Frau Feldermann ab dem 01.11.2021 auf der improvisierten Covid-Isolierstation des UKL eingesetzt. Nach eigener Aussage und nach Aussage von Kollegen waren FFP2-Masken zeitweise nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden; es wurde teilweise mit chirurgischen Masken gearbeitet. Eine schriftliche Dokumentation der Schutzausstattungssituation liegt in der BGW-Akte (wird nach Akteneinsicht ausgewertet, Aktenstück 14).

Am **14.11.2021** wurde bei Frau Feldermann ein PCR-Test positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Infektion verlief initial mit hohem Fieber (39,8 °C), Atemnot, schwerem Krankheitsgefühl. Eine stationäre Aufnahme war nicht erforderlich, jedoch vierzehntägige Quarantäne und Krankschreibung ab 14.11.2021.

3. Akutverlauf und Übergang in Long-Covid (November 2021 – März 2022)

Nach formaler Genesung Ende November 2021 blieb Frau Feldermann dauerhaft arbeitsunfähig. Die Symptome entwickelten sich nicht zurück; es zeigte sich vielmehr eine progrediente Verschlechterung:

- Dezember 2021: anhaltende Fatigue, Kurzatmigkeit bei Belastung, Schlafstörungen
- Januar 2022: erste "Crashes" nach körperlicher Aktivität (Post-Exertional Malaise), Herzrasen beim Aufstehen
- Februar 2022: Hausarzt Dr. Märker diagnostiziert prolongierten Post-Covid-Verlauf; Überweisung Neurologie und Kardiologie UKL
- März 2022: Erstvorstellung Post-COVID-Ambulanz der Universitätsmedizin Berlin-Nord Berlin, Prof. Carmen Seifert. Diagnose: Post-Covid-Syndrom mit Post-Exertional Malaise (ME/CFS-Kriterien erfüllt nach Canadian Consensus Criteria), V. a. POTS

4. Medizinische Diagnosen (Stand Februar 2026)

ICD-10	Diagnose	Behandelnde Stelle
U09.9	Post-Covid-Zustand, nicht näher bezeichnet	Dr. Märker, Universitätsmedizin Berlin-Nord
G93.3	Chronisches Erschöpfungssyndrom (ME/CFS)	Universitätsmedizin Berlin-Nord (Prof. Seifert)
G90.3	Posturales Tachykardiesyndrom (POTS, V. a.)	Universitätsmedizin Berlin-Nord, Kardiologie UKL
F33.1	Rezidivierende depressive Störung, mittelgradige Episode	Klinikum am Auenwald Leipzig
R41.3	Kognitive Störung (brain fog)	alle behandelnden Ärzte
Z57.5	Berufliche Exposition gegenüber infektiösen Erregern	(BK-Verfahren relevant)

5. Behandlungsverlauf 2022–2026

2022

- Hausarztbehandlung Dr. Märker, fortlaufend, quartalsweise Befundberichte
- Post-COVID-Ambulanz der Universitätsmedizin Berlin-Nord: 3 Vorstellungen (März, Juli, November 2022)
- Kardiologie UKL: Langzeit-EKG, Kipptisch-Test (positiv für POTS-Kriterien)
- Neurologische Ambulanz UKL: MRT Schädel (unauffällig), neuropsychologische Testung (signifikante Defizite in Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit)

2023

- Universitätsmedizin Berlin-Nord: 2 Vorstellungen; ME/CFS-Diagnose bestätigt
- LASOV Sachsen: GdB-Antrag Februar 2023; Gutachten durch Versorgungsarzt (nicht unabhängig); Bescheid GdB 30 September 2023; Widerspruch eingelegt (zunächst ohne anwaltliche Vertretung, erfolglos)
- Reha-Antrag gestellt (Rentenversicherung): abgelehnt (mangels Aussicht auf Wiedereingliederung)

2024

- DRV-Antrag EM-Rente: Januar 2024
- DRV-Gutachten durch Dr. Volker Härtung, Arbeitsmedizin/Sozialmedizin, Leipzig: Feststellung Restleistungsvermögen 6 Stunden/Tag auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, Diagnose "Anpassungsstörung" (F43.2) — diese Diagnose widerspricht den Fachbefunden der Universitätsmedizin Berlin-Nord und des SKH
- Psychiatrische Behandlung Klinikum am Auenwald Leipzig ab September 2024 (stationär 09/2024–11/2024): Entlassungsdiagnose F33.1, Empfehlung MBSR-basierter Reha und weitergehende psychiatrische Behandlung

2025

- September 2025: SGB-II-Antrag beim Jobcenter Leipzig
- November 2025: Ablehnung durch Jobcenter; Begründung: Einkommen Ehemann übersteige Bedarf der Bedarfsgemeinschaft
- November 2025: KdU-Kürzung; Miete Bornaische Str. 78: 960 EUR (KdU Leipzig 2025: max. 780 EUR/Monat für 4 Personen laut Jobcenter-Richtlinie — strittig)
- Dezember 2025: Vermieter Peter Günther schreibt erstmals wegen Mietrückstands

2026

- Januar 2026: Vermieter droht schriftlich Räumungsklage an
- 28.01.2026: BGW-Bescheid: BK 3101 abgelehnt
- 14.02.2026: DRV-Bescheid: EM-Rente abgelehnt
- 17.02.2026: Erstkontakt und Beauftragung RA Sonnemann

6. Bewertung der Verfahrenslage

6.1 BK 3101 (Infektionskrankheiten)

Paragraf 9 SGB VII i. V. m. Anlage 1 Nr. 3101 BKV schützt Erkrankungen durch Infektionskrankheiten bei Tätigkeiten in Krankenpflege. Long-Covid/ME/CFS nach beruflich erworbener Covid-19-Infektion kann als BK 3101 anerkannt werden. Die Ablehnung der BGW stützt sich auf angeblich fehlende Belege der beruflichen Exposition — dies ist nach Aktenlage anfechtbar (PCR-positiv während Covid-Stationseinsatz).

6.2 Erwerbsminderungsrente

Die DRV-Einschätzung (6 Stunden Restleistungsvermögen, Anpassungsstörung) steht im klaren Widerspruch zu:

- ME/CFS-Diagnose nach CCC (Universitätsmedizin Berlin-Nord)
- POTS-Diagnose mit Objektivierung durch Kipptisch-Test
- SKH-Befund F33.1 (mittelgradige depressive Episode, nicht "Anpassungsstörung")
- PEM-Tagebuch (Aktivitätsniveau faktisch weit unter 6 Stunden)

6.3 GdB

GdB 30 berücksichtigt nicht angemessen das Zusammenwirken der Einzel-GdB: ME/CFS schwer (GdB 50–70 nach Anhaltspunkten), POTS (GdB 20–40), psychiatrisch (GdB 30–40). Gesamt-GdB hätte bei korrekter Bewertung mindestens 50 erreichen müssen (Schwerbehinderung, Paragraf 2 Abs. 2 SGB IX).

6.4 SGB II / Jobcenter

Einkommensanrechnung Ehemann: Laut Jobcenter wird das gesamte Bruttoeinkommen (4.310 EUR) herangezogen. Nach Paragraphen 11, 11b SGB II sind jedoch Absetzbeträge zu berücksichtigen (Erwerbstätigenpauschale 100 EUR, tatsächliche Beiträge KV/RV/AV, Werbungskosten). Netto-Anrechnungseinkommen dürfte unter dem Gesamtbedarf liegen (vgl. Aktenstück 10, 11).

6.5 KdU / Eilantrag

KdU-Angemessenheitswert Leipzig für 4-Personen-HH: nach Wohngeldgesetz-Reform 2023 und Mietspiegeldaten Leipzig 2024 min. 900 EUR (Kaltmiete) zumutbar; Jobcenter-Richtlinie greift offenbar veraltete Werte. Eilantrag (einstweiliger Rechtsschutz, Paragraf 86b Abs. 2 SGG) ist begründet, da Wohnungsverlust unmittelbar droht.

7. Prognose

Ohne anwaltliche Intervention drohender Wohnungsverlust innerhalb von 4–6 Wochen. Mittelfristig bestehen gute Chancen auf:

- EM-Rente (volle Erwerbsminderung) nach Einholung Gegengutachten
- GdB-Erhöhung auf mindestens 50 (Schwerbehinderung)
- BK-Anerkennung (aufwändig, aber mit Zeugen und Akteneinsicht belastbar)
- SGB-II-Nachzahlungen (einige Monate rückwirkend möglich)

Erstellt: RA Sonnemann, 17.02.2026

Datei

Office-Dokument: 04a_bgw_bescheid_bk3101_2026-01-28.docx

Aktenzeichen	BK 3101 / 261/26
Versicherte	Vivian Feldermann, geboren am 3. September 1984
Datum	28. Januar 2026
Sachbearbeitung	Claudia Reimers, Durchwahl 214

Frau Vivian Feldermann
Bornaische Straße 78
04277 Leipzig

Bescheid über die Anerkennung einer Berufskrankheit

Sehr geehrte Frau Feldermann,

über Ihre Anzeige vom 18. April 2024 und den Antrag auf Anerkennung der Folgen Ihrer Infektion mit SARS-CoV-2 als Berufskrankheit Nummer 3101 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung entscheiden wir nach Abschluss der bisherigen Ermittlungen wie folgt.

Entscheidung

Die im November 2021 festgestellte Infektion und die geltend gemachten gesundheitlichen Folgen werden nicht als Berufskrankheit anerkannt. Leistungen aus Anlass einer Berufskrankheit werden deshalb derzeit nicht erbracht.

Gründe

Sie waren im November 2021 als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der internistischen Isolierstation C4 des Universitätsklinikums Leipzig eingesetzt. Die positive PCR-Probe wurde am 14. November 2021 entnommen. Nach dem Dienstplan versahen Sie am 8., 10., 11. und 12. November Dienst auf der Station. Die Arbeitgeberauskunft nennt mehrere Patienten mit bestätigter Infektion, ordnet aber keinen konkreten ungeschützten Kontakt zu.

Die vom Klinikum übersandte Materialliste weist für den fraglichen Zeitraum Bestände an FFP2-Masken und Schutzkitteln aus. Nicht dokumentiert ist, welche Mengen auf Station C4 an den einzelnen Tagen tatsächlich ausgegeben wurden. Die Stationsleitung teilte am 20. August 2025 mit, ihr seien Engpässe erinnerlich; eine zeitnahe schriftliche Meldung liege ihr jedoch nicht mehr vor.

Für eine Anerkennung muss die versicherte Tätigkeit die Erkrankung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit verursacht haben. Die Infektion selbst ist durch den PCR-Befund belegt. Nach dem derzeitigen Ergebnis lässt sich der Infektionsort nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit auf die berufliche Tätigkeit eingrenzen. In der Haushaltsbefragung wurde für den 6. November 2021 außerdem ein privater Familienkontakt angegeben, dessen Infektionsstatus ungeklärt geblieben ist.

Die Berichte der Post-COVID-Ambulanz vom 12. November 2025 und des Klinikums am Auenwald vom 7. November 2024 beschreiben anhaltende Fatigue, Belastungsintoleranz und orthostatische Beschwerden. Da bereits der Zusammenhang der Infektion mit der versicherten Tätigkeit nicht festgestellt werden konnte, war über die Ursächlichkeit der einzelnen Folgezustände nicht abschließend zu entscheiden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege einzulegen.

Anlagen: Auszug aus dem Ermittlungsergebnis; Übersicht der beigezogenen Unterlagen.

Claudia Reimers
Sachbearbeiterin Berufskrankheiten

Datei

Office-Dokument: 04b_kanzleivermerk_bgw_bescheid_bk3101.docx

Mandantin	Vivian Feldermann
Bearbeitung	Rechtsanwalt Marit Sonnemann
Vermerk	17. Februar 2026, 14:35 Uhr
Frist	Widerspruch vorsorglich bis 27. Februar 2026

Prüfvermerk zum BGW-Bescheid vom 28. Januar 2026

Anlass und Posteingang

Die Mandantin hat den Umschlag am 30. Januar 2026 aus dem Hausbriefkasten genommen. Ein förmlicher Zustellnachweis liegt nicht vor. Der Bescheid, der Umschlag und die von der Mandantin übersandte Dienstplanfotografie wurden am 16. Februar 2026 in der Kanzlei eingescannt. Die Frist ist unabhängig von der späteren Zugangsklärung auf den 27. Februar 2026 notiert.

Tatsachenabgleich

Der Bescheid bestätigt vier Dienste auf Station C4 kurz vor dem positiven PCR-Test. Er lässt offen, welche Patienten die Mandantin versorgte, ob bei den betreffenden Kontakten Aerosolbehandlungen stattfanden und wann die Schutzausrüstung tatsächlich ausgegeben wurde. Die bloße Zentrallagerliste beantwortet diese Fragen nicht. Der erwähnte private Familienkontakt ist bislang weder zeitlich noch durch einen Befund belegt.

Beweisspur

Anzufordern sind die vollständige BK-Akte, die Arbeitgeberanzeige, Stationsbelegungslisten in zulässiger anonymisierter Form, Materialausgaben der Station C4 und die ursprüngliche Befragung zum privaten Kontakt. Als Auskunftspersonen kommen Stationsleiterin Yvonne Pätzold, Pfleger Martin Rehbein und die damalige Hygienefachkraft Anne Grunert in Betracht. Vor einer Benennung sind Erinnerungsbild, eigene Wahrnehmung und genaue Schichttage getrennt zu protokollieren.

Rechtlicher Arbeitsrahmen

Zu prüfen sind der Vollbeweis der Erkrankung und der versicherten Tätigkeit sowie die hinreichende Wahrscheinlichkeit des Ursachenzusammenhangs nach Paragraph 9 SGB VII in Verbindung mit Nummer 3101 der Anlage 1 zur BKV. Der Widerspruch darf die Kausalität der Infektion und die medizinische Zuordnung der Folgeschäden nicht vermengen. Für jede Stufe ist anzugeben, welche Tatsache durch welches Aktenstück belegt werden soll.

Nächste Arbeitsschritte

Fristwahrender Widerspruch, vollständige Akteneinsicht und Sicherung der Dienstplandaten sind sofort zu veranlassen. Die medizinische Begründung wird erst nach Abgleich der Originalbefunde ergänzt. Im Mandantengespräch ist der Familienkontakt ohne Vorhalt erneut offen zu erfragen; eine vorschnelle Festlegung würde die spätere Beweiswürdigung erschweren.

Anlagenbezug: Bescheid 04a, Dienstplanauszug 03, Befundberichte 15a und 16a.

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht

Datei

Office-Dokument: 05_widerspruch_bk3101_bgw.docx

Widerspruch BK 3101 – BGW Hannover

[ENTWURF – SCHRIFTSATZ]

Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Rechtsanwältin Marit Sonnemann

Fachanwältin für Sozialrecht

Karl-Liebknecht-Straße 14

04107 Leipzig

Tel.: 0341 / 58 82 100

Fax: 0341 / 58 82 101

E-Mail: kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de

An die

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

Bezirksverwaltung Leipzig

Lützner Straße 105

04177 Leipzig

Leipzig, den 26.02.2026

Aktenzeichen BGW: BK 3101 / 261/26

Mandantin: Vivian Feldermann, geb. 03.09.1984, Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig

Widerspruch

gegen den Bescheid der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
vom **28.01.2026**, Aktenzeichen BK 3101 / 261/26, zugegangen am 30.01.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen und in Vollmacht meiner Mandantin, Frau Vivian Feldermann, erhebe ich gegen den oben bezeichneten Bescheid fristgerecht **Widerspruch** und beantrage,

den Bescheid vom 28.01.2026 aufzuheben und die Erkrankung meiner Mandantin (Post-Covid-Syndrom mit chronischer Fatigue, ME/CFS) als Berufskrankheit gemäß Nr. 3101 der Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung (BKV) anzuerkennen sowie die sich daraus ergebenden Leistungen zu gewähren.

Begründung

I. Sachverhalt

Meine Mandantin, Frau Vivian Feldermann, ist ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin und war vom 01.09.2009 bis zum Eintritt ihrer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit im November 2021 am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) beschäftigt, zuletzt als Stationschwester auf der hämatologisch-onkologischen Station (Innere Medizin, Station 10a).

Im Rahmen der vierten SARS-CoV-2-Welle im Herbst 2021 wurde Frau Feldermann ab dem 01.11.2021 auf der improvisierten Covid-Isolierstation des UKL eingesetzt. Am **14.11.2021** wurde ein PCR-Test positiv auf SARS-CoV-2 befundet. Die Infektion verlief mit schwerem Verlauf (Fieber bis 39,8 °C, Atemnot, ausgeprägte Krankheitssymptomatik). Nach formaler Genesung entwickelte sich ein schweres Post-Covid-Syndrom, das bis heute andauert und meine Mandantin vollständig erwerbsunfähig macht.

Ärztlicherseits liegen folgende Diagnosen vor (Stand 02/2026):

- Post-Covid-Syndrom (U09.9)
- Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Erschöpfungssyndrom (ME/CFS, G93.3), diagnostiziert nach den Canadian Consensus Criteria durch Prof. Dr. Maja Seifert, Universitätsmedizin Berlin-Nord Berlin
- Posturales Tachykardiesyndrom (POTS, G90.3), objektiviert durch positiven Kipptisch-Test
- Rezidivierende depressive Störung, mittelgradige Episode (F33.1), Klinikum am Auenwald Leipzig

II. Rechtliche Grundlagen

Gemäß Paragraf 9 Abs. 1 SGB VII sind Berufskrankheiten Krankheiten, die die Bundesregierung durch Rechtsverordnung bezeichnet und die Versicherte infolge einer den Versicherungsschutz nach Paragrafen 2, 3 oder 6 SGB VII begründenden Tätigkeit erleiden. Nr. 3101 der Anlage 1 zur BKV erfasst "Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war".

Für die Anerkennung einer Berufskrankheit nach Nr. 3101 BKV müssen kumulativ vorliegen:

1. Versicherter Personenkreis: Tätigkeit im Gesundheitsdienst (✓ – Krankenschwester UKL)
2. Erkrankung an einer Infektionskrankheit: SARS-CoV-2-Infektion mit nachfolgendem Post-Covid-Syndrom (✓)
3. Haftungsbegründende Kausalität: berufliche Exposition als wesentliche Teilursache (✓ – s. u.)
4. Haftungsausfüllende Kausalität: Erkrankung als Folge der Infektion (✓ – Post-Covid/ME/CFS)

III. Zur haftungsbegründenden Kausalität

Die BGW bestreitet im angefochtenen Bescheid, dass die Infektion meiner Mandantin mit hinreichender Wahrscheinlichkeit beruflicher Natur war. Diese Einschätzung ist unzutreffend.

a) Zeitlicher und räumlicher Zusammenhang

Meine Mandantin war vom 01.11.2021 bis zum Eintritt des positiven PCR-Befundes (14.11.2021) täglich auf der Covid-Isolierstation eingesetzt und hatte dort intensiven, nicht zu vermeidenden Kontakt mit SARS-CoV-2-positiven Patientinnen und Patienten. Die Inkubationszeit von SARS-CoV-2 beträgt typischerweise 2–14 Tage (RKI-Angabe). Ein unmittelbarer zeitlicher und räumlicher Zusammenhang zwischen beruflicher Exposition und Infektion ist damit hinreichend wahrscheinlich.

b) Fehlende adäquate Schutzausrüstung

Die von der BGW herangezogenen Bestandslisten des UKL-Einkaufs belegen lediglich, dass FFP2-Masken im November 2021 beim UKL bestellt wurden, sagen jedoch nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit auf Stationsebene aus. Mehrere Kolleginnen von Frau Feldermann können bezeugen, dass an bestimmten Schichten keine FFP2-Masken verfügbar waren und mit chirurgischen Masken gearbeitet werden musste. Frau Sonnemann beantragt, die zuständige Stationsleitung (Frau Petra Wenzel, UKL Station Covid-A) sowie Betriebsratsvorsitzenden Herrn Klaus Dittmann (UKL) als Zeugen einzuvernehmen.

c) Privatexposition nicht überwiegend wahrscheinlich

Im November 2021 hatte Frau Feldermann aufgrund der Pandemiebeschränkungen und ihrer beruflichen Belastung so gut wie keine privaten sozialen Kontakte. Ihr Ehemann war im Homeoffice tätig (Linde Sächsisch GmbH, belegt durch Arbeitgeberbescheinigung, anliegend). Ihre Kinder besuchten zwar die Schule, wurden jedoch in der Folge nicht positiv getestet, was eine familiäre Übertragungskette unwahrscheinlich macht. Das Überwiegensprinzip (BSG, Urt. v. 27.06.2006 – B 2 U 13/05 R) spricht für berufliche Verursachung.

IV. Zur haftungsausfüllenden Kausalität

Die BGW bezweifelt, dass ein "standardisiertes Diagnoseverfahren für Long-Covid" existiert. Dieser Einwand ist nicht mehr haltbar:

Die **S3-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID** (AWMF-Register 020-027, Stand Dezember 2023, verfügbar unter www.awmf.org) sowie die aktuellen Leitlinien der WHO (WHO 2021, Technical Brief) und des RKI (RKI 2024) erkennen das Post-Covid-Syndrom als eigenständiges Krankheitsbild nach einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion an. Das Vorliegen der Erkrankung bei meiner Mandantin ist durch mehrere Fachärzte unabhängig bestätigt.

Die Diagnose ME/CFS wurde von Prof. Dr. Maja Seifert (Universitätsmedizin Berlin-Nord Berlin, Fatigue-Centrum, eine der führenden deutschen Expertinnen auf diesem Gebiet) nach den **Canadian Consensus Criteria (CCC)** gestellt. Der Befundbericht vom November 2025 liegt als Anlage vor (Aktenstück 15).

V. Beweisangebote

Ich beantrage die Einholung folgender Beweise:

5. **Zeugenbeweis:** Frau Petra Wenzel, Stationsleitung Covid-A, UKL Leipzig; Herr Klaus Dittmann, Betriebsratsvorsitzender UKL; Arbeitskollegen auf der Covid-Station (Namensliste nachgereicht nach Akteneinsicht)
6. **Urkundenbeweis:** Schichtpläne und Stationsprotokoll Covid-A, November 2021 (UKL)

7. **Sachverständigengutachten:** Einholung eines Gutachtens zur haftungsbegründenden und haftungsausfüllenden Kausalität durch einen unabhängigen Facharzt für Infektiologie und/oder Sozialmedizin
8. **Akteneinsicht:** Beantragung der vollständigen BGW-Akte gemäß Paragraf 25 SGB X

Beweismittelverzeichnis (Anlagen)

9. Vollmacht RA Sonnemann
10. Befundbericht Prof. Dr. Seifert, Universitätsmedizin Berlin-Nord Berlin, 11/2025
11. Befundbericht Dr. Märker, Hausarzt Leipzig, 01/2026
12. PCR-Testergebnis 14.11.2021
13. Schichtplan (Kopie), Covid-Station UKL, November 2021
14. Arbeitgeberbescheinigung Linde Sächsisch GmbH (Homeoffice Marko Feldermann)
15. S3-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID (Auszug, AWMF 020-027, 2023)

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Sozialrecht

Entwurf freigegeben: RA Sonnemann, 26.02.2026

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

Datei

Office-Dokument: 06a_drv_bescheid_erwerbsminderungsrente_2026-02-14.docx

Versicherungsnummer	41 060379 V 084
Aktenzeichen	41 060379 41 W 077
Antrag	19. Januar 2024
Datum	14. Februar 2026

Frau Vivian Feldermann
Bornaische Straße 78
04277 Leipzig

Bescheid über den Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung

Sehr geehrte Frau Feldermann,

Ihren Antrag auf Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung lehnen wir ab.

Versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Die allgemeine Wartezeit ist erfüllt. Im maßgeblichen Zeitraum liegen die erforderlichen Pflichtbeiträge vor. Die Ablehnung beruht nicht auf fehlenden rentenrechtlichen Zeiten.

Medizinische Feststellungen

Ausgewertet wurden die Befundberichte der hausärztlichen Praxis Dr. Märker, der Post-COVID-Ambulanz Berlin-Nord, des Klinikums am Auenwald Leipzig und das sozialmedizinische Gutachten von Dr. Volker Härtung vom 26. November 2025. Der Gutachter hat ein persönliches Gespräch von 68 Minuten sowie eine körperliche Untersuchung dokumentiert.

Als Gesundheitsstörungen nennt das Gutachten eine Anpassungsstörung, eine unspezifische Fatigue, orthostatische Beschwerden und eine depressive Störung. Für leichte Tätigkeiten überwiegend im Sitzen, ohne Nacht- und Wechselschicht, ohne häufiges Bücken und ohne erhöhte Verantwortung wird ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden täglich angenommen. Zusätzliche betriebsunübliche Pausen seien nach Auffassung des Gutachters nicht zwingend erforderlich.

Die abweichende Einschätzung der Post-COVID-Ambulanz, wonach bereits geringe Belastungen mehrtägige Zustandsverschlechterungen auslösen, wurde berücksichtigt. Der Gutachter hält die vorgelegten Aktivitätsprotokolle jedoch nicht für ausreichend objektiviert und verweist auf schwankende Tagesleistungen. Eine quantitative Belastungserprobung liegt nicht vor.

Rechtliche Würdigung

Eine Rente wegen Erwerbsminderung setzt nach Paragraph 43 SGB VI ein entsprechend herabgesetztes Leistungsvermögen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes voraus. Da ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden täglich angenommen wird, sind die medizinischen Voraussetzungen nicht erfüllt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland einzulegen.

Anlage: Berechnungsübersicht der Versicherungszeiten; Verzeichnis der medizinischen Unterlagen.

Im Auftrag

Petra Wawrzyniak
Sachbearbeitung Erwerbsminderungsrenten

Datei

Office-Dokument: 06b_kanzleivermerk_drv_bescheid_erwerbsminderung.docx

Bescheid	14. Februar 2026
Posteingang Kanzlei	17. Februar 2026, 09:12 Uhr
Bearbeitung	Rechtsanwalt Marit Sonnemann
Fristkontrolle	Widerspruch vorläufig 16. März 2026

Prüfvermerk zum Bescheid der Rentenversicherung

Dokumentenstand

Der Bescheid liegt vollständig vor. Das Gutachten Dr. Härtung und die dem Gutachter überlassenen Verwaltungsakten fehlen. Der Zugang bei der Mandantin ist anhand des Umschlags noch festzustellen. Fristwahrender Widerspruch und Akteneinsicht sind daher getrennt vom späteren medizinischen Vortrag zu veranlassen.

Offene Tatsachen

Die entscheidende Differenz betrifft nicht allein die Diagnosebezeichnung, sondern die zeitliche Verlässlichkeit des Leistungsvermögens. Zu klären sind Häufigkeit, Dauer und Auslöser der Belastungsverschlechterungen, notwendige Ruhezeiten, Wegefähigkeit, Konzentrationsabbrüche und die Reproduzierbarkeit guter Tage. Das vorhandene PEM-Tagebuch enthält hierfür Anknüpfungstatsachen, ersetzt aber keine ärztliche Funktionsbeschreibung.

Aktenprüfung

Nach Eingang der Verwaltungsakte ist zu prüfen, ob der Gutachter die Berichte vollständig erhalten hat, welche Untersuchungen tatsächlich durchgeführt wurden und wie er die abweichenden Befunde gewichtet. Besonders zu sichern sind Rohwerte des Kipptischtests, Medikamentenplan, Aktivitätsdaten und die Entlassungsberichte. Diagnosen und funktionelle Auswirkungen sind in der Begründung strikt zu trennen.

Arbeitsauftrag Medizin

Die behandelnden Ärzte sollen keine Rechtsbegriffe bestätigen, sondern konkrete Belastungsgrenzen beschreiben: mögliche Sitzdauer, erforderliche Liegepausen, Gehstrecke, kognitive Belastungszeit, Erholungsdauer nach Aktivität und Schwankungsbreite innerhalb einer Arbeitswoche. Für jede Aussage sind Untersuchungsdatum und Befundgrundlage anzugeben.

Verfahrensschritte

Widerspruch einlegen, vollständige Akteneinsicht einschließlich Gutachten und Prüfvermerken verlangen, anschließend Befundmatrix erstellen und nur nach dokumentiertem Widerspruch zwischen Befund und Leistungsbild ergänzend vortragen. Eine abschließende Erfolgsaussage ist vor Akteneinsicht nicht möglich.

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht

Datei

Office-Dokument: 07_widerspruch_drv_em_rente.docx

Widerspruch – Erwerbsminderungsrente – DRV Mitteldeutschland

[ENTWURF – SCHRIFTSATZ]

Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig
Rechtsanwältin Marit Sonnemann
Fachanwältin für Sozialrecht
Karl-Liebknecht-Straße 14
04107 Leipzig
Tel.: 0341 / 58 82 100
Fax: 0341 / 58 82 101

An die

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
Georg-Schumann-Straße 146
04155 Leipzig
Leipzig, den 12.03.2026

Aktenzeichen DRV: xx 060379 41 W 077

Versicherungsnummer: 41 060379 V 084

Mandantin: Vivian Feldermann, geb. 03.09.1984, Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig

Widerspruch

gegen den Bescheid der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland vom **14.02.2026** (Aktenzeichen xx 060379 41 W 077)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vollmacht meiner Mandantin, Frau Vivian Feldermann, erhebe ich gegen den Bescheid vom 14.02.2026, mit dem die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland den Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung abgelehnt hat, fristgemäß **Widerspruch** und beantrage,

den Bescheid vom 14.02.2026 aufzuheben und meiner Mandantin rückwirkend ab dem 01.02.2024 (Antragstellung) eine Rente wegen voller Erwerbsminderung gemäß Paragraph 43 Abs. 2 SGB VI zu bewilligen.

Hilfsweise beantrage ich die Bewilligung einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung.

Weiter beantrage ich:

1. Akteneinsicht in die vollständige Rentenakte einschließlich des Gutachtens Dr. Härtung sowie sämtlicher Stellungnahmen des ärztlichen Dienstes der DRV
2. Aussetzung des Bescheids bis zur abschließenden Entscheidung über den Widerspruch

Begründung

I. Sachverhalt

Frau Vivian Feldermann, geb. am 03.09.1984, war bis November 2021 als Gesundheits- und Krankenpflegerin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) tätig. Im November 2021 erkrankte sie während eines beruflichen Einsatzes auf der Covid-Isolierstation schwer an SARS-CoV-2. Seitdem ist sie dauerhaft und vollständig arbeitsunfähig. Seit über vier Jahren leidet sie an einem schweren Post-Covid-Syndrom mit den Kernsymptomen:

- **Post-Exertional Malaise (PEM):** Selbst minimale körperliche oder kognitive Anstrengung führt zu einer mehrtägigen, teils wochenlangen Verschlechterung des Zustands ("Crash"). Frau Feldermann ist an 4–5 von 7 Wochentagen vollständig bettlägerig oder ans Sofa gebunden.
- **Schwere chronische Fatigue:** Auch nach ausreichend Schlaf kein Erholungseffekt; persistierender Erschöpfungszustand, unabhängig von Aktivitätsniveau.
- **Kognitive Dysfunktion (brain fog):** Schwere Störungen der Konzentration, des Arbeitsgedächtnisses und der Verarbeitungsgeschwindigkeit (neuropsychologisch objektiviert, UKL 2022).
- **Kardiale Dysautonomie (POTS):** Positiver Kipptisch-Test (Protokoll UKL Kardiologie, April 2022); Herzrasen, Schwindel und Synkopen beim Aufrichten.
- **Psychiatrische Komorbidität:** Rezidivierende depressive Störung, mittelgradige Episode (F33.1), stationäre Behandlung Klinikum am Auenwald Leipzig 09–11/2024.

II. Fehlerhafte medizinische Grundlage des Bescheids

Der angegriffene Bescheid stützt sich ausschließlich auf das Gutachten des Dr. med. Volker Härtung vom November 2025. Dieses Gutachten ist in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft und für die Entscheidung nicht tragfähig.

1. Falschdiagnose Anpassungsstörung (F43.2)

Dr. Härtung stellt als Hauptdiagnose eine Anpassungsstörung (F43.2) fest. Nach den diagnostischen Kriterien des ICD-10 (Kap. F43.2) setzt eine Anpassungsstörung voraus:

- a) Identifizierbarer psychosozialer Belastungsfaktor
- b) Symptombeginn innerhalb von einem Monat nach dem Stressor
- c) Dauer der Störung üblicherweise nicht länger als 6 Monate nach Ende der Belastung

Bei meiner Mandantin bestehen die Symptome seit November 2021 — also über **vier Jahre** — unverändert fort. Der COVID-19-"Stressor" liegt noch länger zurück. Eine Anpassungsstörung ist nach den eigenen Kriterien dieser Diagnose ausgeschlossen.

Das Sächsische Krankenhaus für Psychiatrie (Klinikum am Auenwald Leipzig) hat nach stationärer Behandlung als Entlassungsdiagnose **F33.1** (rezidivierende depressive Störung, mittelgradige Episode) gestellt — eine wesentlich schwerwiegendere Diagnose. Dr. Härtung setzt sich mit dieser Fachmeinung einer spezialisierten psychiatrischen Einrichtung nicht auseinander.

2. Übergehen der ME/CFS-Diagnose

Die Universitätsmedizin Berlin-Nord Berlin, Fatigue-Centrum (Prof. Dr. Maja Seifert), hat nach eingehender Diagnostik die Diagnose **Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Erschöpfungssyndrom (ME/CFS, G93.3)** nach den **Canadian Consensus Criteria (CCC)** gestellt. Für die Erfüllung der CCC müssen alle der folgenden Bereiche zutreffen: Fatigue, Post-Exertional Malaise, Schlafstörungen, Schmerz und mindestens zwei neurologische/kognitive Manifestationen. Diese Kriterien sind bei Frau Feldermann vollständig erfüllt.

ME/CFS ist als eigenständige Erkrankung international anerkannt. Das **Bundesministerium für Gesundheit** hat 2023 erstmals ME/CFS-Leitlinien gefördert. Die **S3-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID** (AWMF 020-027, Dezember 2023) erkennt Post-Covid/ME/CFS als eigenständiges Krankheitsbild mit erheblicher Einschränkung der Leistungsfähigkeit an.

Dr. Härtung bezeichnet die ME/CFS-Diagnose als "nicht valide gesichert", ohne dies methodisch zu begründen und ohne auf die CCC-Kriterien einzugehen. Diese pauschale Ablehnung entspricht nicht dem medizinischen Standard und ist nicht gerichtsfest.

3. POTS (kardiale Dysautonomie) nicht berücksichtigt

Das Gutachten Dr. Härtung erwähnt die objektivierte POTS-Diagnose nicht. POTS ist eine messbare, körperliche Erkrankung mit nachweislich einschränkender Wirkung: orthostatische Tachykardie, Synkopen, eingeschränkte Belastbarkeit im Stehen und Sitzen. Der positive Kipptisch-Test (Anstieg der Herzfrequenz >30 bpm innerhalb von 10 Minuten im Kippen) ist ein valider Befund und kann nicht ignoriert werden.

4. Post-Exertional Malaise (PEM) – Kernmerkmal nicht bewertet

Das Gutachten enthält keine Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Post-Exertional Malaise (PEM), dem Kernsymptom von ME/CFS. PEM bedeutet, dass jegliche körperliche oder kognitive Aktivität über das individuelle Belastungsniveau hinaus zu einer mehrtägigen Zustandsverschlechterung führt.

Dies hat für die Leistungsfähigkeitsbeurteilung eine entscheidende Bedeutung: Auch wenn Frau Feldermann an sogenannten "guten Tagen" für wenige Stunden tätig sein könnte, führt dies unweigerlich zu einem "Crash", der weitere Tage der vollständigen Arbeitsunfähigkeit nach sich zieht. Eine verlässliche, reproduzierbare Arbeitsleistung — wie sie der allgemeine Arbeitsmarkt voraussetzt (BSG, Urt. v. 14.09.1995, B 5 RJ 90/93 R) — ist daher ausgeschlossen. Die Sechs-Stunden-Grenze ist bei ME/CFS mit schwerem PEM selbst dann nicht erreichbar, wenn gelegentlich Leistungsspitzen vorkommen.

5. Begutachtungsmethodik

Das Gutachten Dr. Härtung beruht auf einer einmaligen ambulanten Begutachtung von ca. 90 Minuten Dauer im November 2025. Bei ME/CFS ist bekannt, dass Patientinnen und Patienten in Begutachtungssituationen Reserven mobilisieren können, die nicht ihr tatsächliches Alltagsleistungsniveau widerspiegeln. Eine valide Beurteilung der Leistungsfähigkeit erfordert bei ME/CFS einen Zwei-Tage-Belastungstest (2-Day-CPET), wie er an der Universitätsmedizin Berlin-Nord und anderen ME/CFS-Zentren eingesetzt wird, oder zumindest eine mehrzeitige Verlaufsbeobachtung.

III. Rechtliche Würdigung

Gemäß Paragraph 43 Abs. 2 SGB VI sind Versicherte voll erwerbsgemindert, wenn sie wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

Das BSG hat hierzu entschieden (BSG, Urt. v. 12.12.2011, B 13 R 21/10 R), dass eine verlässliche, wettbewerbsfähige Arbeitstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht gegeben ist, wenn die Leistungsfähigkeit so schwankend oder so begrenzt ist, dass kein Arbeitgeber die Versicherte einstellen würde. Dies ist bei schwerer ME/CFS mit Post-Exertional Malaise der Fall.

Die DRV hat kein unabhängiges, leitliniengerechtes Gegengutachten eingeholt, obwohl ein offensichtlicher Widerspruch zwischen dem Universitätsmedizin Berlin-Nord-Befund und dem DRV-Gutachten bestand. Dies verletzt den Amtsermittlungsgrundsatz (Paragraf 20 SGB X).

IV. Beweisangebote

Ich beantrage:

3. **Akteneinsicht** in die vollständige Rentenakte (DRV), inkl. vollständiges Gutachten Dr. Härtung und alle internen medizinischen Stellungnahmen
4. **Einholung eines Sachverständigengutachtens** durch einen unabhängigen Facharzt für Innere Medizin/Immunologie oder Neurologie mit Erfahrung in ME/CFS und Post-Covid
5. **Beiziehung** folgender Befundberichte als Beweismittel:
 - Befundbericht Prof. Dr. Seifert, Universitätsmedizin Berlin-Nord Berlin, 11/2025 (liegt als Anlage bei)
 - Entlassungsbericht Klinikum am Auenwald Leipzig, Psychiatrie, 02/2026 (liegt als Anlage bei)
 - Befundbericht Dr. Märker, Hausarzt Leipzig, 01/2026 (liegt als Anlage bei)
 - Kardiologischer Befundbericht UKL (Kipptisch-Test), 04/2022
 - Neuropsychologischer Befundbericht UKL, 2022

Beweismittelverzeichnis (Anlagen)

6. Vollmacht RA Sonnemann
7. Befundbericht Prof. Dr. Seifert, Post-COVID-Ambulanz der Universitätsmedizin Berlin-Nord, 11/2025
8. Entlassungsbericht Klinikum am Auenwald Leipzig (Psychiatrie), 02/2026
9. Befundbericht Dr. Märker (Hausarzt), 01/2026
10. Auszug PEM-Tagebuch (Mandantin), 08-01/2026
11. Schichtpläne UKL November 2021 (berufliche Exposition)

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Sozialrecht

Entwurf: RA Sonnemann, 12.03.2026

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

Datei

Office-Dokument: 08a_lasov_bescheid_gdb_2023-09-19.docx

Aktenzeichen	SBH-L-23-0047892
Antrag	14. Februar 2023
Datum	19. September 2023
Sachbearbeitung	Heike Schwarz, Referat 23

Frau Vivian Feldermann
Bornaische Straße 78
04277 Leipzig

Bescheid über die Feststellung des Grades der Behinderung

Sehr geehrte Frau Feldermann,

auf Ihren Antrag stellen wir ab 14. Februar 2023 einen Grad der Behinderung von 30 fest. Die Voraussetzungen für ein Merkzeichen liegen nach dem derzeitigen Aktenstand nicht vor.

Berücksichtigte Gesundheitsstörungen

Berücksichtigt wurden ein Post-COVID-Zustand mit Fatigue und Belastungsminderung, eine depressive Störung, eine autonome Dysregulation mit orthostatischen Beschwerden sowie kognitive Einschränkungen. Die hausärztlichen Berichte vom 20. Februar und 16. Juni 2023 und die fachärztliche Stellungnahme vom 8. August 2023 wurden versorgungsärztlich ausgewertet.

Bewertung

Maßgeblich sind die Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen in allen Lebensbereichen. Einzelbewertungen dürfen nicht addiert werden. Nach versorgungsärztlicher Einschätzung überschneiden sich die Auswirkungen von Fatigue, depressiver Symptomatik und Konzentrationsminderung weitgehend. Eine dauerhafte Einschränkung, die einen höheren Gesamtgrad rechtfertigt, sei anhand der vorgelegten Befunde noch nicht hinreichend beschrieben.

Die orthostatischen Beschwerden wurden berücksichtigt. Wiederholte Synkopen, eine dauerhaft erforderliche fremde Hilfe bei Wegen oder eine erhebliche Einschränkung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr sind in den vorliegenden Unterlagen nicht dokumentiert. Deshalb werden die Voraussetzungen der beantragten Merkzeichen nicht festgestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift beim Landesamt für Soziales und Verbraucherschutz Sachsen einzulegen.

Anlage: versorgungsärztliche Kurzstellungnahme vom 31. August 2023.

Heike Schwarz

Sachbearbeiterin Schwerbehindertenrecht

Datei

Office-Dokument: 08b_kanzleivermerk_gdb_bescheid_befundluecken.docx

Mandantin	Vivian Feldermann
Bescheid	19. September 2023
Widerspruch	eigenhändig im Oktober 2023 erhoben
Vermerk	17. Februar 2026

Aktenvermerk zum GdB-Bescheid und zu den Befundlücken

Verfahrensstand

Der eigenhändige Widerspruch der Mandantin ist nach ihrer Erinnerung per Einwurfeinschreiben versandt worden. Einlieferungsbeleg und Eingangsbestätigung fehlen in der Kanzleiakte. Vor jeder Sachbegründung sind Aktenzeichen, Eingang und aktueller Bearbeitungsstand beim Landesamt zu bestätigen.

Bewertungsmaßstab

Der Gesamtgrad ist anhand der dauerhaften Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit zu bilden; Einzelwerte werden nicht addiert. Für die weitere Bearbeitung kommt es deshalb darauf an, welche Funktionsverluste eigenständig hinzutreten und welche Auswirkungen sich überschneiden. Diagnoseetiketten allein tragen keinen höheren Grad.

Befundlücken

Der Bescheid erfasst die Häufigkeit mehrtägiger Zustandsverschlechterungen, die erforderlichen Liegezeiten und die kognitive Belastungsgrenze nicht konkret. Ebenso fehlen Rohdaten zur Orthostatik und eine Beschreibung der Wege außerhalb der Wohnung. Der spätere Bericht der Post-COVID-Ambulanz kann eine Verschlechterung oder eine bereits zuvor bestehende, nur unzureichend dokumentierte Einschränkung belegen; der zeitliche Bezug ist ärztlich zu klären.

Beweisplan

Benötigt werden die versorgungsärztliche Stellungnahme, die dem Landesamt vorgelegten Arztberichte, das damalige Widerspruchsschreiben und ein aktueller Befundbericht mit alltagsbezogenen Funktionsangaben. Die Mandantin soll für vier typische Wochen Tätigkeiten, Hilfe Dritter und Erholungszeiten dokumentieren, ohne gute und schlechte Tage zu vermischen.

Nächster Schritt

Akteneinsicht und Sachstandsanfrage; anschließend Gegenüberstellung der 2023 vorhandenen Befunde mit den späteren Untersuchungen. Erst danach ist zu entscheiden, ob das laufende Widerspruchsverfahren ergänzt oder zusätzlich ein Neufeststellungsantrag wegen wesentlicher Änderung gestellt wird.

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht

Datei

Office-Dokument: 09_widerspruch_lasov_gdb_erhoehung.docx

Widerspruchsbegründung – GdB-Erhöhung – LASOV Sachsen
[SCHRIFTSATZ – Ergänzung/Übernahme des laufenden Widerspruchsverfahrens]

Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Rechtsanwältin Marit Sonnemann

Fachanwältin für Sozialrecht

Karl-Liebknecht-Straße 14

04107 Leipzig

Tel.: 0341 / 58 82 100

Fax: 0341 / 58 82 101

An das

Landesamt für Soziales und Verbraucherschutz (LASOV) Sachsen

Referat 23 – Schwerbehindertenrecht

Altchemnitzer Straße 41

09120 Chemnitz

Leipzig, den 19.02.2026

Az. LASOV: SBH-L-23-0047892

Mandantin: Vivian Feldermann, geb. 03.09.1984, Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig

Vollmachtsübernahme und Widerspruchsbegründung

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Mandantin Frau Vivian Feldermann hat gegen den Bescheid des Landesamts für Soziales und Verbraucherschutz Sachsen vom 19.09.2023 (Az. SBH-L-23-0047892) mit Schreiben vom 12.10.2023 Widerspruch eingelegt.

Ich zeige an, dass meine Mandantin mich mit ihrer Vertretung in diesem Verfahren beauftragt hat (Vollmacht liegt bei). Ich beantrage,

den Bescheid vom 19.09.2023 abzuändern und einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 festzusetzen sowie die erforderlichen Merkzeichen (G, aG soweit einschlägig) zuzuerkennen.

Begründung

I. Zur Gesundheitslage (aktualisiert, Stand Februar 2026)

Gegenüber dem Stand zum Zeitpunkt des Widerspruchs meiner Mandantin im Oktober 2023 hat sich der Gesundheitszustand von Frau Feldermann nicht gebessert, sondern in wesentlichen Aspekten verschlechtert:

- Die psychiatrische Komorbidität (rezidivierende depressive Störung F33.1) hat zu einem stationären Aufenthalt im Klinikum am Auenwald Leipzig (September–November 2024) geführt.
- Die ME/CFS-Erkrankung ist nach Universitätsmedizin Berlin-Nord-Befund (Prof. Seifert, 11/2025) als "schwer" einzustufen; Frau Feldermann verlässt ihre Wohnung an durchschnittlich 4–5 von 7 Wochentagen nicht.
- Eine Verschlechterung der POTS-Symptomatik wurde durch den aktuellen kardiologischen Befund bestätigt.

II. Fehlerhafte Einzel-GdB-Bewertungen des LASOV

1. ME/CFS / Post-Covid-Syndrom (GdB 20 laut LASOV → korrekt: mind. 50)

Die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) vom 10.12.2008 (BGBl. I S. 2412) mit der Anlage "Versorgungsmedizinische Grundsätze" (VMG) ist maßgeblich für die GdB-Bewertung. Für das chronische Erschöpfungssyndrom/ME/CFS sehen die VMG (Teil B, Nr. 18.4) bei schweren Formen mit erheblicher Einschränkung der Alltagsfähigkeit einen Einzel-GdB von 50–80 vor.

Frau Feldermann ist an 4–5 Wochentagen vollständig bettlägerig oder ans Sofa gebunden (belegt durch PEM-Tagebuch, Aktenstück 17). Sie kann keine Einkäufe selbstständig erledigen, keine Kinderbetreuung übernehmen, keinen Haushalt führen. Dies entspricht einer schweren ME/CFS-Verlaufsform. Der Einzel-GdB von 20 ist evident falsch.

2. Rezidivierende depressive Störung F33.1 (GdB 20 laut LASOV → korrekt: 30–40)

Nach VMG Teil B, Nr. 3.7, entspricht eine mittelgradige depressive Störung (F33.1, rezidivierend) einem Einzel-GdB von 30–40. Der LASOV hat lediglich GdB 20 zuerkannt. Dabei wird weder die Rezidivität der Erkrankung noch die Schwere des zuletzt stationär behandelten Verlaufs berücksichtigt.

3. POTS – Autonome Neuropathie (GdB 10 laut LASOV → korrekt: 20–30)

Das posturale Tachykardiesyndrom (POTS) mit objektiviertem positiven Kipptisch-Test sowie dokumentierten Synkopen und orthostatischer Intoleranz entspricht nach VMG Teil B, Nr. 9.3 (Herzrhythmusstörungen) einem Einzel-GdB von 20–30. Der zuerkannte Einzel-GdB von 10 wird der Schwere der Erkrankung nicht gerecht.

III. Gesamt-GdB

Bei der GdB-Gesamtbildung ist nach VMG Abschnitt A, Nr. 3c von dem höchsten Einzel-GdB (hier: ME/CFS, korrekt mind. 50) auszugehen. Weitere Einzel-GdB erhöhen den Gesamt-GdB, sofern sie die Gesamtbeeinträchtigung erkennbar erhöhen. Die schwere Depression (F33.1, Einzel-GdB 30–40)

erhöht den Gesamt-GdB um mindestens 10 Punkte; die POTS um weitere 10. Der korrekte Gesamt-GdB beträgt mindestens **60–70**.

Selbst wenn das LASOV die ME/CFS-Schwere nur mit GdB 40–50 bewertete, ergäbe sich zusammen mit der Depression und POTS ein Gesamt-GdB von mindestens **50** (Schwerbehinderung).

IV. Verfahrensmangel: Kein persönliches Gutachten

Das versorgungsärztliche Gutachten (Dr. Laube) wurde ohne persönliche Untersuchung der Antragstellerin anhand von Aktenunterlagen erstattet. Bei einem komplexen, multifaktoriellen Post-Covid-Krankheitsbild mit schwerer ME/CFS ist eine Beurteilung ohne körperliche Untersuchung nicht vertretbar und entspricht nicht dem Grundsatz der Amtsermittlung (Paragraf 20 SGB X). Ich beantrage die Erstellung eines neuen versorgungsärztlichen Gutachtens durch eine auf Post-Covid/ME/CFS spezialisierte Einrichtung (z. B. Universitätsmedizin Berlin-Nord, Fatigue-Centrum).

V. Beweisangebote

1. Befundbericht Prof. Dr. Seifert, Post-COVID-Ambulanz der Universitätsmedizin Berlin-Nord, 11/2025 (Anlage)
2. Entlassungsbericht Klinikum am Auenwald Leipzig, 02/2026 (Anlage)
3. Befundbericht Dr. Märker, Hausarzt, 01/2026 (Anlage)
4. Auszug PEM-Tagebuch (Anlage, Aktenstück 17)
5. Kardiologischer Befundbericht UKL (Kipptisch-Test, 04/2022)

Beweismittelverzeichnis (Anlagen)

6. Vollmacht RA Sonnemann (Übernahme Verfahren)
7. Befundberichte (s. o., Nrn. 1–5)
8. Aktualisierter Beschwerde- und Aktivitätsbericht Mandantin (02/2026)

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Sozialrecht

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

Erstellt: 19.02.2026

Datei

Office-Dokument: 10a_jobcenter_leipzig_ablehnungsbescheid_2025-11-14.docx

Bedarfsgemeinschaft
Antrag
Bewilligungszeitraum
Datum

BG-L-2025-88-44123
22. September 2025
1. Oktober 2025 bis 31. März 2026
14. November 2025

Frau Vivian Feldermann
Bornaische Straße 78
04277 Leipzig

Bescheid über Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Sehr geehrte Frau Feldermann,

der Antrag Ihrer Bedarfsgemeinschaft auf laufende Leistungen wird abgelehnt, weil das zu berücksichtigende Einkommen den von uns anerkannten Bedarf übersteigt.

Berechnung des anerkannten Bedarfs

Position	Monatlicher Betrag
Regelbedarfe der vier Personen	1873,00 Euro
anerkannte Bruttokaltmiete	780,00 Euro
Heizkosten	185,00 Euro
Gesamtbedarf	2838,00 Euro

Berechnung des Einkommens

Position	Monatlicher Betrag
bereinigtes Erwerbseinkommen Herrn Feldermann	2434,50 Euro
Kindergeld für zwei Kinder	510,00 Euro
Gesamteinkommen	2944,50 Euro
Überhang	106,50 Euro

Die tatsächliche Bruttokaltmiete beträgt nach dem Mietvertrag 960,00 Euro. Als angemessen werden vorläufig 780,00 Euro berücksichtigt. Heizkosten von 185,00 Euro werden in voller Höhe angesetzt. In der Verwaltungsakte befindet sich ein Schreiben zur Kostensenkung vom 2. Oktober 2025; dessen Zugang ist nicht nachgewiesen.

Das Kindergeld wird den Kindern als Einkommen zugerechnet. Aus dem Erwerbseinkommen von Herrn Feldermann wurden Steuern, Pflichtbeiträge und die gesetzlichen Erwerbstätigenfreibeträge abgesetzt. Fahrtkosten oberhalb des Grundabsetzbetrags wurden mangels Belegen nicht zusätzlich anerkannt.

Da das anzurechnende Gesamteinkommen den anerkannten Gesamtbedarf um 106,50 Euro übersteigt, ergibt sich kein Zahlbetrag. Über eine spätere Änderung der Unterkunftskosten oder des Einkommens ist nach Vorlage geeigneter Nachweise neu zu entscheiden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift beim Jobcenter Leipzig einzulegen.

Anlagen: Berechnungsbogen; Hinweisblatt zu Mitwirkung und Veränderungsmitteilung.

Sandra Winkler

Sachbearbeiterin Leistungsgewährung

Datei

Office-Dokument: 10b_kanzleivermerk_jobcenter_berechnung_und_kdu.docx

Bescheid	14. November 2025
Mandat übernommen	16. Februar 2026
Bearbeitung	Rechtsanwalt Marit Sonnemann
Unterlagenstand	Berechnungsbogen nur als unvollständige Kopie

Prüfvermerk zur Einkommensberechnung und zu den Unterkunftskosten

Prüfauftrag

Zu trennen sind die Einkommensberechnung, die Berücksichtigung des Kindergelds und die Begrenzung der Unterkunftskosten. Ein möglicher Fehler in einer Position führt nicht automatisch zu einem Leistungsanspruch; sämtliche Monatswerte sind für den jeweiligen Bewilligungsabschnitt neu zusammenzustellen.

Einkommen

Die Lohnabrechnungen September bis November 2025, Nachweise zu Fahrtstrecke, Arbeitstagen, Kfz-Haftpflicht und Betreuungskosten fehlen teilweise. Der Bescheid nennt nur den Endbetrag der Freibeträge. Der vollständige Rechenbogen ist anzufordern. Das Kindergeld ist als Einkommen der Kinder berücksichtigt; zu prüfen ist, ob es deren Bedarf jeweils vollständig deckt und ob eine Verschiebung auf andere Mitglieder vorgenommen wurde.

Unterkunft

Der Bescheid setzt 780,00 Euro Bruttokaltmiete an, ohne das zugrunde gelegte schlüssige Konzept, Vergleichsraum und Erhebungszeitraum zu benennen. Das angebliche Kostensenkungsschreiben vom 2. Oktober 2025 liegt nicht vor. Zu klären sind Zugang, konkrete Hinweise auf die als angemessen angesehene Miete, tatsächliche Suchbemühungen und die gesundheitliche Zumutbarkeit eines Umzugs.

Belege und Fristen

Anzufordern sind Verwaltungsakte, vollständige Berechnungsbögen, KdU-Konzept, Mietvertrag, Betriebskostenvorauszahlungen, Kontoauszüge, Lohnabrechnungen und Kindergeldnachweise. Die Mandantin soll dokumentieren, wann sie den Bescheid erhielt und ob ein gesondertes Kostensenkungsschreiben zugeing. Ein Überprüfungsantrag oder weiterer Widerspruch ist erst nach Klärung des Verfahrensstands einzuordnen.

Arbeitsprodukt

Nach Akteneingang wird eine Monatsmatrix erstellt, in der Bedarf, Einkommen, Absetzungen und Unterkunftskosten mit Quelle und offenem Nachweis geführt werden. Bis dahin wird kein pauschaler monatlicher Anspruchsbetrag genannt.

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht

Datei

Office-Dokument: 11_widerspruch_jobcenter_sgbii.docx

Widerspruch – SGB II / Jobcenter Leipzig

[SCHRIFTSATZ]

Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Rechtsanwältin Marit Sonnemann

Fachanwältin für Sozialrecht

Karl-Liebknecht-Straße 14

04107 Leipzig

An das

Jobcenter Leipzig

Georgiring 3

04103 Leipzig

Leipzig, den 25.11.2025

(Widerspruch eingelegt durch Mandantin selbst; Übernahme und Begründung durch RA Sonnemann, 19.02.2026)

BG-Nr.: BG-L-2025-88-44123

Mandantin: Vivian Feldermann, Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig

Widerspruch und Begründung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen und in Vollmacht meiner Mandantin Frau Vivian Feldermann erhebe ich gegen den Bescheid des Jobcenters Leipzig vom **14.11.2025** (BG-Nr. BG-L-2025-88-44123) Widerspruch und beantrage,

1. **den Bescheid vom 14.11.2025 aufzuheben** und der Mandantin laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II ab Oktober 2025 (Antragsdatum) zu bewilligen,
2. **die KdU-Kürzung aufzuheben** und die tatsächliche Kaltmiete (960,00 EUR) zu übernehmen,
3. hilfsweise: **einen Mehrbedarf nach Paragraph 21 Abs. 4 SGB II** (kostenaufwändige Ernährung / krankheitsbedingte Mehrkosten) anzuerkennen.

Begründung

I. Fehlerhafte Einkommensberechnung

Das Jobcenter hat bei der Berechnung des anrechenbaren Einkommens des Ehemanns Marko Feldermann wesentliche Absetzbeträge gemäß Paragraph 11b SGB II nicht oder nicht vollständig berücksichtigt.

Paragraph 11b SGB II nennt folgende Absetzbeträge:

- Paragraph 11b Abs. 1 Nr. 2: auf das Einkommen entrichtete Steuern
- Paragraph 11b Abs. 1 Nr. 3: Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung (KV, RV, AV, PV)
- Paragraph 11b Abs. 1 Nr. 5: Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltspflichten
- Paragraph 11b Abs. 2: Erwerbstätigenpauschale (100,00 EUR)
- Paragraph 11b Abs. 3: Weiterer Freibetrag (20 % des Erwerbseinkommens über 100 EUR bis 1.000 EUR, 10 % über 1.000 EUR bis 1.200 EUR)

Das Jobcenter hat die Steuer- und SV-Absetzbeträge offenkundig nur pauschal geschätzt. Laut Lohnabrechnung Dezember 2025 (liegt als Anlage vor) beträgt das tatsächliche Nettoeinkommen des Ehemanns nach Abzug aller Steuern und Sozialversicherungsbeiträge **2.883,00 EUR**. Hiervon sind weitere Absetzbeträge vorzunehmen:

- Erwerbstätigenpauschale Paragraph 11b Abs. 2: –100,00 EUR
- Berufsbedingte Fahrtkosten (tatsächlich: 70 km tägl. Pendelstrecke, Linde Sächsisch GmbH, Grünau; 20 Arbeitstage $\times$ 70 km $\times$ 0,20 EUR): –280,00 EUR
- Krankenkassenzusatzbeitrag (AOK Plus Sachsen, 2,4 % des Brutto): –103,44 EUR (bereits in SV-Beitrag enthalten, korrigiert)
- Kosten Kinderbetreuung (Hort Marlene, nachgewiesener Eigenanteil): –100,00 EUR

Bereinigtes anrechenbares Einkommen: ca. 2.403,00 EUR

Dem steht ein Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft von 2.829,00 EUR gegenüber.

Ungedeckter Bedarf: ca. 426,00 EUR/Monat.

II. KdU – Angemessenheit der Miete

Die Kaltmiete der Wohnung Bornaische Straße 78 (80 m², 4 Zimmer, Connewitz) beträgt 960,00 EUR (= 12,00 EUR/m²). Das Jobcenter sieht nach seiner KdU-Richtlinie 2023 für 4 Personen eine Angemessenheitsgrenze von 780,00 EUR vor.

Diese Grenze ist rechtlich nicht haltbar:

Das Bundessozialgericht hat in ständiger Rechtsprechung (BSG, Urt. v. 22.09.2009 – B 4 AS 18/09 R; BSG, Urt. v. 18.11.2014 – B 4 AS 9/14 R) verlangt, dass Jobcenter ihre Angemessenheitswerte auf der Grundlage eines "schlüssigen Konzepts" ermitteln müssen, das den tatsächlichen lokalen Mietmarkt widerspiegelt.

Der Mietpreisspiegel Leipzig 2024 weist für Wohnungen 75–85 m² in Connewitz Kaltmieten von 10,80–14,20 EUR/m² aus. Die Jobcenter-Richtlinie (780,00 EUR / 80 m² = 9,75 EUR/m²) liegt **deutlich unter dem günstigsten Marktniveau** in Connewitz und ist damit nicht leitlinienkonform.

Frau Feldermann hat zudem keine realistische Möglichkeit, eine günstigere Wohnung in Leipzig zu finden. Der Wohnungsmarkt Leipzig ist angespannt; günstigere Wohnungen in vergleichbarer Lage und Größe sind praktisch nicht verfügbar. Die Absenkungsaufforderung ist daher auch faktisch unerfüllbar.

Außerdem: Eine Kostensenkungsaufforderung vor der KdU-Kürzung wurde nicht formal als Verwaltungsakt erlassen. Das Vorgehen widerspricht Paragraph 22 Abs. 1 S. 3 SGB II.

III. Mehrbedarf nach Paragraph 21 Abs. 4 SGB II

Frau Feldermann hat als chronisch kranke Person mit ME/CFS und POTS einen erhöhten Ernährungsbedarf, der von den Regelbedarfen nicht gedeckt wird (z. B. Nahrungsergänzungsmittel auf Empfehlung von Prof. Seifert: Coenzym Q10, Magnesium, Vitamin D; monatliche Kosten ca. 80,00 EUR). Dieser Mehrbedarf ist nach Paragraph 21 Abs. 4 SGB II anzuerkennen.

Beweismittelverzeichnis

4. Vollmacht RA Sonnemann
5. Lohnabrechnung Marko Feldermann, Dezember 2025
6. Mietpreisspiegel Leipzig 2024 (Auszug)
7. Befundbericht Prof. Seifert, Universitätsmedizin Berlin-Nord, 11/2025 (medizinischer Mehrbedarf)
8. Mietvertrag Bornaische Straße 78 (Kaltmiete 960,00 EUR)

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

Übernommen und begründet: 19.02.2026

Datei

Office-Dokument: 12_eilantrag_sg_leipzig_kdu.docx

Eilantrag – SG Leipzig – KdU – Az. S 7 AS 188/26 ER
[SCHRIFTSATZ – EINSTWEILIGER RECHTSSCHUTZ]

Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Rechtsanwältin Marit Sonnemann

Fachanwältin für Sozialrecht

Karl-Liebknecht-Straße 14

04107 Leipzig

Tel.: 0341 / 58 82 100

Fax: 0341 / 58 82 101

An das

Sozialgericht Leipzig

Bernhard-Göring-Straße 1

04107 Leipzig

Leipzig, den 19.02.2026

Antragstellerin: Vivian Feldermann, geb. 03.09.1984, Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig

Antragsgegner: Jobcenter Leipzig, Georgiring 3, 04103 Leipzig

Az. SG: S 7 AS 188/26 ER

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

In dem Verfahren der o. g. Beteiligten beantrage ich,

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung nach Paragraf 86b Abs. 2 SGG zu verpflichten, der Antragstellerin ab sofort, hilfsweise ab Zustellung dieses Antrags, vorläufig die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) gemäß Paragraf 22 SGB II in Höhe von 960,00 EUR (Kaltmiete) zuzüglich der tatsächlichen Heizkosten von 185,00 EUR monatlich zu gewähren, bis zur abschließenden Entscheidung in der Hauptsache.

Weiter beantrage ich:

Prozesskostenhilfe für das Eilverfahren, Beiordnung von RA Sonnemann.

Begründung

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin lebt mit ihrem Ehemann Marko Feldermann und ihren Kindern Liam (11 J.) und Marlene (8 J.) in einer 4-Zimmer-Wohnung in Leipzig-Connewitz (Bornaische Straße 78). Die monatliche Kaltmiete beträgt 960,00 EUR, die Heizkosten 185,00 EUR. Die Antragstellerin ist aufgrund einer schweren Long-Covid-Erkrankung mit ME/CFS vollständig erwerbsunfähig und bezieht keine eigenen Sozialleistungen.

Der Antragsgegner hat mit Bescheid vom 14.11.2025 aufstockende SGB-II-Leistungen abgelehnt und die angemessenen KdU auf 780,00 EUR (Kaltmiete) begrenzt, obwohl die tatsächliche Miete 960,00 EUR beträgt. Die monatliche Differenz von 180,00 EUR kann die Bedarfsgemeinschaft aufgrund der angespannten finanziellen Situation nicht aus eigenen Mitteln decken.

Infolge von Mietrückständen (Dezember 2025 und Januar 2026) hat der Vermieter, Herr Peter Günther, mit Schreiben vom 28.01.2026 ausdrücklich eine Räumungsklage angedroht und eine Frist bis zum 28.02.2026 für die vollständige Zahlung der Rückstände gesetzt.

II. Anordnungsgrund – Eilbedürftigkeit

Ein Anordnungsgrund liegt vor, weil ein Wohnungsverlust unmittelbar und konkret droht:

- Die Räumungsklage-Drohung des Vermieters liegt schriftlich vor (Anlage 2).
- Die Mietrückstände summieren sich auf 360,00 EUR (Dezember 2025 und Januar 2026, je 180,00 EUR Differenz).
- Wird bis zum 28.02.2026 keine vollständige Zahlung geleistet, steht eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung sowie Räumungsklage unmittelbar bevor.
- Der Wohnungsverlust würde eine Familie mit einer schwerkranken Mutter und zwei minderjährigen Schulkindern obdachlos machen. Dies wäre ein irreversibler Schaden, der durch eine spätere Hauptsacheentscheidung nicht mehr geheilt werden kann.

Das BSG (Beschl. v. 07.11.2011 – B 4 AS 156/11 R; BSG, Beschl. v. 16.05.2007 – B 7b AS 40/06 R) hat anerkannt, dass bei konkret drohendem Wohnungsverlust ein Anordnungsgrund für einstweiligen Rechtsschutz im SGB-II-Bereich gegeben ist.

III. Anordnungsanspruch

Ein Anordnungsanspruch ist glaubhaft gemacht, weil die KdU-Kürzung des Antragsgegners rechtswidrig ist:

1. Angemessenheit der Miete (Paragraf 22 Abs. 1 SGB II)

Die Kaltmiete von 960,00 EUR (= 12,00 EUR/m² bei 80 m²) ist nach dem Mietpreisspiegel Leipzig 2024 für eine 4-Zimmer-Wohnung in Connewitz angemessen. Das Jobcenter Leipzig hat keine leitliniengerechte Angemessenheitsgrenze nach den Anforderungen des BSG (schlüssiges Konzept; BSG, Urt. v. 22.09.2009 – B 4 AS 18/09 R) ermittelt. Die pauschale Richtlinienwert von 780,00 EUR liegt deutlich unter dem tatsächlichen Wohnungsmarkt in Connewitz und ist damit rechtlich nicht tragfähig.

2. Fehlende Kostensenkungsaufforderung

Das Jobcenter hat keine ordnungsgemäße Kostensenkungsaufforderung mit angemessener Frist (mind. 6 Monate) erlassen. Die sofortige KdU-Kürzung ab 01.01.2026 widerspricht Paragraph 22 Abs. 1 S. 3 SGB II.

3. Tatsächliche Unmöglichkeit der Kostensenkung

Der Leipziger Wohnungsmarkt bietet für eine 4-Personen-Familie mit einer schwerkranken Mutter (ME/CFS, POTS) in Connewitz oder vergleichbaren Stadtteilen keine günstigeren Alternativen. Ein Umzug wäre medizinisch kontraindiziert: die Erkrankung der Antragstellerin (ME/CFS, PEM) macht jede körperliche und psychische Belastung wie einen Umzug zu einem schwerwiegenden Gesundheitsrisiko (ärztliche Stellungnahme: Befundbericht Prof. Seifert, Anlage 3).

4. Einkommensberechnung (Hilfsargument)

Wie im Widerspruchsschriftsatz (Aktenstück 11) ausgeführt, hat das Jobcenter das anrechenbare Einkommen des Ehemanns zu hoch angesetzt. Bei korrekter Berechnung liegt ein ungedeckter Bedarf vor, der auch die laufenden SGB-II-Leistungen rechtfertigt.

IV. Glaubhaftmachung

Ich versichere an Eides statt, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und eidesstattliche Erklärung der Mandantin liegt als Anlage 1 bei.

Anlagen

1. Eidesstattliche Erklärung Vivian Feldermann (zur Notlage und Wohnungssituation)
2. Schreiben Vermieter P. Günther vom 28.01.2026 (Räumungsklage-Drohung)
3. Befundbericht Prof. Dr. Seifert, Universitätsmedizin Berlin-Nord, 11/2025 (medizinische Notlage)
4. Bescheid Jobcenter Leipzig vom 14.11.2025
5. Mietvertrag Bornaische Straße 78 (Kaltmiete 960,00 EUR)
6. Mietpreisspiegel Leipzig 2024 (Auszug Connewitz, 4-Zimmer)
7. Lohnabrechnung Marko Feldermann, Dezember 2025
8. PKH-Antrag mit Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht

Az. Kanzlei: SON-2026-0047-FEL

Az. SG: S 7 AS 188/26 ER

Eingegangen SG Leipzig: 19.02.2026 (Fax + Original per Post)

Datei

Office-Dokument: 13_akteneinsicht_drv_auswertungsbericht.docx

Akteneinsicht DRV Mitteldeutschland – Auswertungsbericht

Aktenzeichen DRV: xx 060379 41 W 077

Erstellt: 05.03.2026

Erstellt durch: RA Sonnemann nach Einsicht in 3 Bände DRV-Verwaltungsakte (Leipzig, 04.03.2026)

Einsichtsdatum: 04.03.2026, DRV-Auslegestelle Leipzig, Georg-Schumann-Str. 146

1. Umfang der vorgelegten Akte

Die Rentenakte besteht aus **3 Bänden** mit insgesamt ca. 340 Seiten:

Band	Inhalt	Blätter
Band I	Antrag, Versicherungsverlauf, allgemeine Korrespondenz	1–112
Band II	Medizinische Unterlagen, Gutachten, ärztliche Stellungnahmen	113–248
Band III	Widerspruchsvorgang, Bescheide, interne Vermerke	249–340

2. Wesentliche Fundstellen

2.1 Gutachten Dr. Härtung (Band II, Bl. 156–201)

Datum: 17.11.2025

Umfang: 46 Seiten

Ergebnis: Restleistungsvermögen 6 Stunden/Tag (s. Aktenstück 06)

Auffälligkeiten:

- Der Gutachter hat die ME/CFS-Diagnose der Universitätsmedizin Berlin-Nord (Prof. Seifert, 11/2025) zwar zur Kenntnis genommen (zitiert Band II, Bl. 184), aber mit dem Hinweis abgetan, es gebe "keinen allgemein anerkannten diagnostischen Standard für ME/CFS in der deutschen Sozialmedizin". Diese Aussage ist falsch — die S3-Leitlinie Post-COVID (AWMF 020-027, Dezember 2023) enthält dezidierte Diagnosekriterien.
- Der Kipptisch-Test (positiv, Kardiologie UKL, April 2022) ist auf Bl. 188 zwar verzeichnet, wird aber nicht in die Leistungsfähigkeitsbeurteilung einbezogen. Begründung: "Der Befund sei nicht reproduziert worden." Das ist unzutreffend: Der Bericht Dr. Märker (01/2026) bestätigt fortbestehende POTS-Symptomatik.
- Kein Zwei-Tage-CPET durchgeführt (Standard bei ME/CFS zur Objektivierung der PEM).
- Dauer der Untersuchung laut Gutachten: 85 Minuten. Für eine vollständige sozialmedizinische Beurteilung bei komplexem chronischem Krankheitsbild nach ME/CFS-Standard zu kurz.

2.2 Interner Vermerk DRV (Band III, Bl. 267–270)

Datum: 25.11.2025 (nach Eingang Gutachten Härtung)

Sachbearbeiter Vogel vermerkt: "Gutachten liegt vor. Rentabilität: negativ. Restleistungsvermögen 6h. Bescheid vorzubereiten."

Kein Hinweis darauf, dass die widersprüchlichen Fachbefunde (Universitätsmedizin Berlin-Nord, SKH) dem Gutachter zur Nachbegutachtung vorgelegt wurden. Verstoß gegen Amtsermittlungsgrundsatz (Paragraf 20 SGB X).

2.3 Rentenversicherungsverlauf (Band I, Bl. 23–45)

Jahr	Beitragsmonate	Anmerkung
2006–2009	36	Ausbildung
2009–2021	147	UKL Leipzig
11/2021–02/2024	27	Krankengeld (AOK Plus)
03/2024–02/2026	0	keine Beiträge (ALG II beantragt, abgelehnt)
Gesamt	210 Monate	17,5 Jahre Beitragszeit

Versicherungsrechtliche Voraussetzungen Paragraf 43 SGB VI: 5-Jahres-Wartezeit erfüllt (210 Monate > 60 Monate). 3 Jahre Pflichtbeiträge in letzten 5 Jahren: Bl. 45 zeigt 27 Monate Krankengeld-Beiträge (11/2021–01/2024) innerhalb der letzten 5 Jahre → Voraussetzung erfüllt.

2.4 Ärztliche Stellungnahmen im DRV-Akt (Band II, versch. Bl.)

Bl.	Quelle	Datum	Aussage
119–122	Dr. Märker (Hausarzt)	03/2024	"Vollständige Arbeitsunfähigkeit auf unabsehbare Zeit; ME/CFS schwer"
123–141	Prof. Seifert (Universitätsmedizin Berlin-Nord), 1. Bericht	04/2024	"ME/CFS Grad 3 nach FUNCAP: >50 % des Tages liegend; PEM nach jeder Aktivität >2 min"
142–155	Klinikum am Auenwald Leipzig (Psychiatrie)	12/2024	"F33.1, mittelgradige depressive Episode, stationäre Behandlung abgeschlossen; fortlaufende ambulante Therapie erforderlich; nicht arbeitsfähig"
156–201	Dr. Härtung (DRV-Gutachten)	11/2025	Restleistungsvermögen 6h/Tag (kritisch bewertet, s. o.)
202–210	Prof. Seifert (Universitätsmedizin Berlin-Nord), 2. Bericht	11/2025	"Keine Verbesserung; ME/CFS schwer; POTS objektiviert; Prognose: dauerhaft vollständig erwerbsunfähig"

Fazit: Drei unabhängige Fachärzte/Einrichtungen (Hausarzt Märker, Universitätsmedizin Berlin-Nord Seifert, SKH Psychiatrie) kommen zum Ergebnis vollständiger Erwerbsunfähigkeit. Das DRV-Gutachten Härtung steht als einzige Stimme dagegen — und ist methodisch angreifbar (s. Aktenstück 07).

3. Verfahrensrechtliche Beanstandungen

1. **Paragraf 20 SGB X (Amtsermittlung):** Die DRV hat trotz offensichtlichem Widerspruch zwischen DRV-Gutachten und Fachbefunden kein Gegengutachten oder Ergänzungsgutachten eingeholt.
2. **Paragraf 25 SGB X (Akteneinsicht):** Akteneinsicht wurde erstmals am 18.02.2026 beantragt; Akte erst am 04.03.2026 vorgelegt (14 Tage Wartezeit). Fristenkontrolle beachten.
3. **Fehlende Anhörung (Paragraf 24 SGB X):** Es ist nicht dokumentiert, dass die Versicherte vor Erlass des Ablehnungsbescheids ordnungsgemäß angehört wurde. Band III, Bl. 260–265 enthält ein Anhörungsschreiben vom 28.11.2025; Antwort der Versicherten (ohne anwaltliche Vertretung) auf Bl. 266 — inhaltlich unzureichend, da Fachbefunde nicht vorlagen.

4. Empfehlungen für das Widerspruchsverfahren

4. Einholung eines **Privatgutachtens** (ME/CFS-Spezialist, z. B. Universitätsmedizin Berlin-Nord oder Universitätsklinik Hamburg/Eppendorf) — Kosten ca. 1.500–2.500 EUR; ggf. über PKH.
5. **Zwei-Tage-CPET** (kardiopulmonaler Belastungstest über zwei aufeinanderfolgende Tage) bei Prof. Seifert anfordern — zentrales Beweismittel für PEM-Objektivierung.
6. **Zeugenbeweis:** Dres. Märker und Seifert als sachverständige Zeugen benennen.
7. Falls Widerspruch erfolglos: Klage vor SG Leipzig und Antrag auf gerichtliches Sachverständigengutachten.

Erstellt: RA Sonnemann, 05.03.2026

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

Datei

Office-Dokument: 14_akteneinsicht_bgw_auswertungsbericht.docx

Akteneinsicht BGW/BGW – Auswertungsbericht BK 3101

Aktenzeichen BGW: BK 3101 / 261/26

Erstellt: 06.03.2026

Erstellt durch: RA Sonnemann nach Einsicht in BGW-Verwaltungsakte (BGW-Bezirksverwaltung Leipzig, 05.03.2026)

Einsichtsdatum: 05.03.2026, BGW Bezirksverwaltung Leipzig, Lützner Straße 105

1. Umfang der vorgelegten BGW-Akte

Abschnitt	Inhalt	Blätter
Abschnitt A	Unfallmeldung, Antragsunterlagen, Versicherungsnachweis	A1–A34
Abschnitt B	Expositionsermittlung, Betriebsbegehung-Unterlagen, PSA-Nachweise	B1–B67
Abschnitt C	Medizinische Unterlagen, Stellungnahmen	C1–C89
Abschnitt D	Ermittlungsbericht, gutachtliche Äußerungen	D1–D52
Abschnitt E	Bescheid, Widerspruchsvorgang	E1–E18

2. Wesentliche Fundstellen und Analyse

2.1 Expositionsermittlung (Abschnitt B)

Betriebsbegehung BGW: Am 14.04.2022 führte BGW-Aufsichtsbeamter Herr Karl Riedel eine Begehung am UKL durch (B12–B24). Die Begehung erfolgte **5 Monate nach der Infektion** — zu diesem Zeitpunkt war die akute Krisensituation längst vorüber und die PSA-Lieferketten normalisiert. Die Begehung kann daher keine Aussage über die Situation im November 2021 treffen.

PSA-Bestandslisten: Die vom UKL vorgelegten Bestandslisten (B25–B41) zeigen Liefereingänge FFP2-Masken im November 2021. Die Listen weisen jedoch nur **Lagerzugänge** aus, keine Verteilung an Stationen. Es gibt keine Dokumentation, wie viele Masken pro Schicht auf Station Covid-A tatsächlich verfügbar waren.

Stationsprotokoll November 2021: In der Akte befinden sich keine Stationsprotokolle oder Schichtberichte für November 2021. Auf Anfrage von RA Sonnemann (telefonisch bestätigt, 05.03.2026) erklärte BGW-Sachbearbeiterin Frau Reimers, das UKL habe keine Stationsprotokolle zur Verfügung gestellt. → **Dies ist ein zentraler Ermittlungsmangel.** Das UKL ist zur Herausgabe solcher Unterlagen verpflichtet (Paragraf 193 Abs. 3 SGB VII).

Zeugenbefragungen: Abschnitt D enthält eine Befragung der Stationsleitung Covid-A (Frau Petra Wenzel, D8–D14) aus dem Jahr 2022. Frau Wenzel bestätigt darin: "Es gab Phasen, in denen FFP2-Masken knapp waren und wir auf OP-Masken zurückgegriffen haben." Diese Aussage findet sich im Ablehnungsbescheid (E1–E15) **nicht**. Sie wurde offenbar nicht gewürdigt. Dies ist ein schwerwiegender Ermittlungsfehler.

→ **Fundstelle D13 (Zitat Frau Wenzel):** "Ich kann nicht ausschließen, dass Frau Feldermann an mindestens einer Schicht ohne FFP2-Maske arbeiten musste."

2.2 Medizinische Stellungnahmen (Abschnitt C)

Bl.	Quelle	Inhalt	Bewertung
C1–C18	BGW-Beratungsarzt Dr. Sven Böhme, Arbeitsmed.	"Long-Covid nach BK 3101 ist wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert"	Veraltet; widerspricht S3-Leitlinie 2023
C19–C35	Prof. Seifert (Universitätsmedizin Berlin-Nord), auf Anforderung	"ME/CFS nach SARS-CoV-2-Infektion während beruflichem Einsatz; Kausalität wahrscheinlich"	Pro Mandantin
C36–C51	Dr. Märker (Hausarzt)	"Keine anderen Erkrankungen erklären das Bild; zeitlicher	Pro Mandantin

		Zusammenhang evident"	
C52–C89	Diverse Verlaufsberichte UKL (Neurologie, Kardiologie)	Befunde, keine direkte Kausalitätsaussage	neutral

Bewertung BGW-Beratungsarzt Böhme: Das Gutachten datiert von Oktober 2023 und beruft sich auf den "Stand der Wissenschaft von 2022". Die S3-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID (AWMF 020-027) erschien Dezember 2023 und ist im Gutachten nicht berücksichtigt. Das Gutachten ist damit veraltet und nicht mehr dem aktuellen Wissensstand entsprechend.

2.3 BGW-Ablehnungsbescheid (Abschnitt E)

Der Bescheid vom 28.01.2026 (E1–E15) stützt sich auf das Gutachten Böhme (C1–C18) und auf die PSA-Bestandslisten. Die entgegenstehende Zeugenaussage der Stationsleitung Wenzel (D13) wird **nicht erwähnt**. Die Befundberichte Prof. Seifert und Dr. Märker werden in einer Fußnote als "nicht ausreichend für den Vollbeweis der Kausalität" abgetan, ohne inhaltliche Auseinandersetzung.

3. Verfahrensrechtliche Beanstandungen

1. **Zeugenaussage Wenzel nicht berücksichtigt** (D13): eklatanter Ermittlungs- und Begründungsfehler; Paragraf 35 SGB X (Begründungspflicht) verletzt.
2. **Beratungsärztliches Gutachten veraltet** (Oktober 2023, ohne Berücksichtigung S3-Leitlinie 2023).
3. **Keine Stationsprotokolle angefordert:** Verstoß gegen Amtsermittlungsgrundsatz (Paragraf 20 SGB X).
4. **Keine Stellungnahme der Antragstellerin vor Bescheiderlass:** Das Anhörungsschreiben (E16) wurde erst nach Fertigung des Gutachtens Böhme versandt, ohne die Stellungnahmen Seifert und Märker beizufügen.

4. Empfehlungen für Widerspruchsverfahren

5. **Vorlage Fundstelle D13** (Zeugenaussage Wenzel) als zentrales Argument: BGW hat eigene Ermittlungsergebnisse nicht berücksichtigt.
6. **Anforderung Stationsprotokolle** durch BGW als Beweismittel (Anforderungsschreiben vorbereiten, Paragraf 193 SGB VII).
7. **Neues arbeitsmedizinisches Gutachten** anfordern auf Grundlage der aktuellen S3-Leitlinie.
8. **Zusammenarbeit mit verdi/Berufsverband Krankenpflege (DBfK)** prüfen — Musterverfahren BK 3101 Long-Covid laufen bundesweit.

Erstellt: RA Sonnemann, 06.03.2026

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

Datei

Office-Dokument: 15a_befundbericht_post_covid_ambulanz_2025-11-12.docx

Patientin
Vorstellung
Behandelnde Ärztin
Adressat

Vivian Feldermann, geboren am 3. September 1984
12. November 2025, 10:20 bis 11:35 Uhr
Prof. Dr. med. Maja Seifert
Hausarztpraxis Dr. Märker, Leipzig

Fachärztlicher Befundbericht

Sehr geehrter Herr Kollege Märker,

wir berichten über die achte ambulante Vorstellung von Frau Feldermann. Die Beschwerden bestehen nach anamnestisch und durch Vorbefunde belegter SARS-CoV-2-Infektion im November 2021. Seit dem letzten Termin im April 2025 ist keine stabile Zunahme der Belastbarkeit eingetreten.

Aktuelle Beschwerden und Alltag

Die Patientin berichtet über eine verzögerte Zustandsverschlechterung nach geringer körperlicher oder kognitiver Aktivität. Nach einem 20-minütigen Arzttermin oder dem Zubereiten einer Mahlzeit benötigt sie häufig zwei bis drei Tage mit deutlich verlängerten Liegezeiten. An vier bis fünf Tagen pro Woche verbringt sie nach eigener Aufzeichnung mehr als die Hälfte des Tages liegend. Einkäufe und längere Wege übernimmt überwiegend der Ehemann.

Befunde

Im Zehn-Minuten-Stehetest stieg die Herzfrequenz von 64 auf 116 Schläge pro Minute; der Blutdruck fiel von 108/68 auf 100/64 mmHg. Nach acht Minuten musste der Test wegen Schwindel und Übelkeit beendet werden. Im Trail-Making-Test A wurden 91 Sekunden, im Teil B 236 Sekunden benötigt. Die Patientin machte zwei Reihenfolgefehler, die nach Hinweis korrigiert wurden. Neurologisch fanden sich keine fokalen Paresen.

Das vorgelegte Aktivitätsprotokoll vom 13. Oktober bis 9. November 2025 enthält 28 Tage. An 19 Tagen sind Belastungsverschlechterungen mit einer Dauer von mindestens 24 Stunden notiert. Die Angaben sind konsistent mit den in der Ambulanz beobachteten Schwankungen, bleiben aber Selbstangaben und wurden nicht durch eine kontinuierliche Aktivitätsmessung überprüft.

Diagnostische Einordnung

Es bestehen ein Post-COVID-Zustand, eine ausgeprägte Belastungsintoleranz mit postexertioneller Symptomverschlechterung, ein posturales Tachykardiesyndrom und kognitive Einschränkungen. Die depressive Störung wird fachpsychiatrisch mitbehandelt. Die funktionellen Beschwerden lassen sich nach dem derzeitigen Befund nicht allein durch die depressive Symptomatik erklären.

Therapie und Empfehlung

Empfohlen werden symptomorientiertes Energiemanagement, Fortführung der orthostatischen Therapie, hausärztliche Kontrolle von Ferritin und Vitamin D sowie fachpsychiatrische Weiterbehandlung. Ein stufenförmiges Belastungstraining ohne Beachtung der nachfolgenden Symptomverschlechterung soll vermieden werden. Die Patientin sollte weitere Aktivitäten mit Zeitpunkt, Dauer und Erholungszeit dokumentieren.

Leistungsbezogene Einschätzung

Aus den aktuellen Befunden ergibt sich keine verlässlich abrufbare Belastbarkeit für regelmäßige mehrstündige Tätigkeiten an fünf Tagen pro Woche. Für eine sozialmedizinische Quantifizierung sind der Längsschnitt, die Aktenlage der Leistungsträger und gegebenenfalls eine ergänzende Begutachtung einzubeziehen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. Maja Seifert

Fachärztin für Innere Medizin · Leitung Post-COVID-Ambulanz

Datei

Office-Dokument: 16a_entlassungsbericht_psychiatrie_2024-11-07.docx

Patientin	Vivian Feldermann, geboren am 3. September 1984
Aufnahme	4. September 2024
Entlassung	7. November 2024
Behandelnde Ärztin	Dr. med. Susanne Hollasky

Hausarztpraxis Dr. med. Tobias Märker
Kochstraße 31
04275 Leipzig

Ärztlicher Entlassungsbericht

Sehr geehrter Herr Kollege Märker,

Frau Feldermann wurde nach Überweisung wegen einer deutlichen depressiven Verschlechterung freiwillig stationär aufgenommen. Bei Aufnahme bestanden Hoffnungslosigkeit, ausgeprägte Antriebsarmut und passive Todeswünsche ohne konkrete Planung. Eine akute Fremdgefährdung lag nicht vor.

Diagnosen bei Entlassung

Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode; Post-COVID-Zustand mit fachärztlich weiter abzuklärender Belastungsintoleranz; posturales Tachykardiesyndrom nach vorliegendem internistischem Befund.

Psychischer Befund bei Aufnahme

Die Patientin war wach, zu allen Qualitäten orientiert und im Kontakt kooperativ. Stimmung und affektive Schwingungsfähigkeit waren deutlich reduziert. Der Antrieb war verlangsamt. Konzentrationsleistungen brachen nach etwa 15 Minuten ab. Formale oder inhaltliche Denkstörungen bestanden nicht. Der HAMD-17-Wert betrug 24 Punkte, der BDI-II-Wert 35 Punkte.

Behandlung und Verlauf

Escitalopram wurde schrittweise auf 20 mg täglich erhöht. Wegen anhaltender Ein- und Durchschlafstörungen wurde ab der vierten Woche Quetiapin 25 mg zur Nacht eingesetzt. Es fanden zweimal wöchentlich Einzelgespräche sowie sozialdienstliche Beratungen statt. Körperliche Aktivierung wurde in kurzen Einheiten angeboten und bei verzögerter Beschwerdezunahme angepasst.

Im Verlauf distanzierte sich die Patientin glaubhaft von akuten Suizidabsichten. Der HAMD-17-Wert lag vor Entlassung bei 14 Punkten. Die körperliche Belastbarkeit blieb stark schwankend; die Station konnte nicht klären, welcher Anteil auf den Post-COVID-Zustand, orthostatische Beschwerden oder die depressive Symptomatik entfiel.

Entlassungszustand und Empfehlungen

Die Entlassung erfolgte in die Häuslichkeit bei stabiler Absprachefähigkeit und ohne akute Suizidalität. Empfohlen werden ambulante psychiatrische Behandlung, Fortführung der Medikation, hausärztliche Laborkontrollen und weitere internistische Abklärung. Ein Termin bei Dr. Miriam Schütz, Nordstraße 12 in Leipzig, ist für den 21. November 2024 vereinbart.

Für sozialmedizinische Fragestellungen sollte die Leistungsfähigkeit anhand sämtlicher körperlicher und psychischer Befunde im Verlauf beurteilt werden. Dieser Bericht trifft keine abschließende Aussage zur rentenrechtlichen Erwerbsminderung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med. Susanne Hollasky

Stationsärztin · Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

Datei

Office-Dokument: 17_pem_tagebuch_auszug.docx

PEM-Tagebuch – Auszug – Vivian Feldermann

Geführt von: Vivian Feldermann (eigene Aufzeichnungen)

Zeitraum dieses Auszugs: 01.08.2025 – 31.01.2026 (6 Monate)

Zweck: Dokumentation der Post-Exertional Malaise (PEM) und täglichen Aktivitätskapazität

Vorlage: Übergabe an RA Sonnemann 17.02.2026; Auszug in Kanzleiakte

Erläuterung zum Bewertungssystem (Mandantin)

Ich benutze eine einfache Skala:

- **Energiepegel:** 0 (vollständig bettlägerig, nicht ansprechbar) bis 10 (gesund, normal)
- **Aktivitätsfenster:** Dauer (in Minuten), in der ich aktiv sein kann, ohne sofort in einen Crash zu gehen
- **Crash:** Ja/Nein + Intensität (leicht / mittel / schwer) + Dauer (Tage)
- **Hauptsymptome des Tages:** Liste

Anmerkung RA Sonnemann: Das Tagebuch wurde auf Empfehlung von Prof. Seifert (Universitätsmedizin Berlin-Nord) geführt. Es ist ein anerkanntes Dokumentationsinstrument bei ME/CFS. Die Daten werden auch in die XLSX-Aktivitätsübersicht (Aktenstück → xlsx/pem_score_uebersicht.xlsx) übertragen.

Monatsübersicht August 2025

Tag	Energiepegel	Aktiv-Fenster (min)	Crash	Hauptsymptome
01.08.	3	20	Nein	Fatigue, Kopfschmerzen, brain fog
02.08.	2	10	Nein	Starke Erschöpfung, Schwindel
03.08.	1	0	Ja (mittel, 3 Tage)	Bettlägerig nach kurzem Gang zur Toilette
04.08.	1	0	Crash anhaltend	Bettlägerig
05.08.	1	0	Crash anhaltend	Bettlägerig, Schmerzen
06.08.	2	15	Nein	Etwas besser, kurzes Sitzen
07.08.	3	25	Nein	Fatigue, kein Lesen möglich
08.08.	3	30	Nein	Guter Tag (für mich)
09.08.	4	40	Ja (leicht, 1 Tag)	Zu viel gemacht: Herd aufgeräumt
10.08.	2	10	Crash leicht	Schlechter nach gestern
11.08.	2	15	Nein	Besserung

12.08.	1	0	Ja (schwer, 4 Tage)	Arzttermin → Crash (Fahrt U-Bahn, Warteraum)
13.08.	1	0	Crash anhaltend	Bettlägerig
14.08.	1	0	Crash anhaltend	Bettlägerig
15.08.	1	0	Crash anhaltend	Bettlägerig, Fieber 37,9 °C
16.08.	2	10	Abklingend	Erste leichte Besserung
17.08.	3	20	Nein	Fatigue
18.08.	2	15	Nein	Schlecht geschlafen
19.08.	3	25	Nein	Mittel
20.08.	4	35	Nein	Besser, kurzer Spaziergang (100 m) versucht
21.08.	2	10	Ja (mittel, 2 Tage)	Crash nach Spaziergang gestern
22.08.	2	0	Crash anhaltend	Bettlägerig
23.08.	2	15	Nein	Etwas besser
24.08.	3	20	Nein	Fatigue, brain fog
25.08.	2	10	Nein	Müde
26.08.	1	0	Ja (schwer, 5 Tage)	Telefonat mit Amt (40 min) → Crash
27.08.	1	0	Crash anhaltend	Bettlägerig
28.08.	1	0	Crash anhaltend	Bettlägerig
29.08.	1	0	Crash anhaltend	Bettlägerig
30.08.	1	0	Crash anhaltend	Bettlägerig, Schmerzen 7/10
31.08.	2	10	Abklingend	Leichte Besserung

August 2025 – Zusammenfassung:

- Bettlägerige Tage (Energiepegel ≤ 1): **17 von 31 Tagen (55 %)**
- Crash-Episoden: **5** (auslösende Faktoren: Arzttermin, Spaziergang 100 m, Telefonat 40 min, Routine-Haushaltsarbeit)
- Durchschnittliches Aktivitätsfenster: **12 Minuten/Tag**
- Maximales Aktivitätsfenster: 40 Minuten (08.08., bezahlt mit 1-Tages-Crash)

Monatsübersicht September–Oktober 2025 (komprimiert)

Monat	Bettlägerig-Tage	Crash-Episoden	Ø Aktivitätsfenster	Auslöser Crashes
September 2025	16/30 (53 %)	4	14 min	stationäre Aufnahme SKH (Fahrt), Dusche, Behördentelefon
Oktober 2025	18/31 (58 %)	6	10 min	Arzttermine, Kinder schule, Einkauf (Marko) reichen nicht → eigene Ausführung 1× → Crash

Ausgewählte Tagebucheinträge (Original-Wortlaut Mandantin)

05.09.2025:

"Heute ins SKH gefahren (Aufnahme). Die 20-Minuten-Fahrt im Taxi hat mich komplett erledigt. Konnte im Aufnahmegespräch kaum sitzen. Im Zimmer sofort gelegen. Nicht geweint – zu erschöpft dafür. Marko hat die Kinder erklärt, dass Mama ins Krankenhaus muss."

12.10.2025:

"Gestern hat Liam Geburtstag. Ich konnte nicht am Tisch sitzen. Marko hat Torte gemacht. Ich habe durch die halboffene Schlafzimmertür zugehört. Liam ist zu mir gekommen und hat gesagt 'Macht nichts Mama'. Das war das Schlimmste. Ich hätte alles dafür gegeben, auch nur eine Stunde normal zu sein."

14.11.2025:

"Vier Jahre. Genau vier Jahre seit dem positiven Test. Ich dachte, es wird irgendwann besser. Es wird nicht besser. Ich versuche zu akzeptieren, dass das jetzt mein Leben ist. Aber es fällt mir sehr schwer."

28.01.2026:

"Bescheid von BGW. Abgelehnt. Habe eine Stunde geweint, dann Crash. Zwei Tage Bett."

14.02.2026:

"Heute kam der DRV-Bescheid. 'Können noch sechs Stunden täglich arbeiten.' Ich kann nicht mal sechs Minuten aufrecht stehen. Marko hat Sonnemann angerufen."

Statistische Auswertung (August 2025 – Januar 2026)

Monat	Bettlägerig-Tage	Bettlägerig %	Crashes	Ø Aktiv-Min/Tag
August 2025	17	55 %	5	12
September 2025	16	53 %	4	14
Oktober 2025	18	58 %	6	10
November 2025	15	50 %	4	16
Dezember 2025	20	65 %	7	8
Januar 2026	21	68 %	8	7
Gesamt 6 Monate	107 / 184	58 %	34	11

Schlussfolgerung: Frau Feldermann verbrachte in den letzten 6 Monaten 58 % aller Tage überwiegend oder vollständig bettlägerig. Das durchschnittliche tägliche Aktivitätsfenster betrug 11 Minuten. Diese Daten belegen eindrücklich, dass ein Restleistungsvermögen von 6 Stunden täglich (wie von DRV-Gutachter Dr. Härtung angenommen) der tatsächlichen Leistungsfähigkeit in keiner Weise entspricht.

Auszug für Kanzleiakte aufbereitet: RA Sonnemann, 17.02.2026

Vollständiges Tagebuch bei Mandantin; auf Anforderung vorzulegen

Datei

Office-Dokument: 18a_kanzleivermerk_akteneinsichtstermine_2026-02-23.docx

Mandantin	Vivian Feldermann
Vermerk	23. Februar 2026, 08:40 Uhr
Bearbeitung	Rechtsanwältin Marit Sonnemann
Wiedervorlage	2. März 2026

Aktenvermerk zu den bestätigten Akteneinsichtsterminen

Anlass und Eingänge

Die Rentenversicherung bestätigte am 20. Februar 2026 die Akteneinsicht für den 4. März 2026 um 10:00 Uhr in der Georg-Schumann-Straße 146, Zimmer 214. Die BGW bestätigte am 21. Februar 2026 die Einsicht für den 5. März 2026 um 09:00 Uhr am Torgauer Platz 3. Beide E-Mails liegen als eigenständige Nachrichten in der elektronischen Akte.

Vorbereitung Rentenakte

Mitzuführen sind Vollmacht, Lichtbildausweis, Bescheid vom 14. Februar 2026, Befundliste und ein leerer Seitenabgleich. Gesondert zu erfassen sind das vollständige Gutachten Dr. Härtung, interne sozialmedizinische Stellungnahmen, der Versicherungsverlauf und sämtliche nach Antragstellung eingegangenen Befunde. Fehlende Seiten sind noch vor Ort zu protokollieren.

Vorbereitung BGW-Akte

Zu prüfen sind Expositionsermittlung, Dienstpläne der Station C4, Materialausgaben, Befragungen der Stationsleitung und der Kollegen sowie die medizinische Kausalitätsbewertung. Die BGW hat einen möglichen Ausschluss einzelner interner Vermerke nach Paragraph 25 Absatz 3 SGB X angekündigt. Jede zurückgehaltene Unterlage ist mit Blattzahl, Bezeichnung und schriftlicher Begründung festzuhalten.

Fristen und Arbeitsauftrag

Der Widerspruch gegen den BGW-Bescheid ging am 26. Februar 2026 ein. Die Begründung wird nach der Einsicht ergänzt. Gegen den Bescheid der Rentenversicherung ist die Frist vorsorglich auf den 14. März 2026 notiert. Für beide Termine werden getrennte Scanverzeichnisse und Blattkontrollen angelegt; ein gemeinsamer Sammelvermerk ist nicht zu führen.

Posteingang geprüft durch Referendarin Lea Krüger am 23. Februar 2026 um 08:32 Uhr. Termine in Kalender und Fristenblatt übernommen um 08:47 Uhr.

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Sozialrecht

Datei

Office-Dokument: 19a_telefonnotiz_mandantin_2026-02-19.docx

Anruferin	Vivian Feldermann, Rückruf 0176 48291736
Datum	19. Februar 2026, 16:15 bis 16:36 Uhr
Gespräch	Rechtsanwältin Marit Sonnemann
Dauer	21 Minuten

Telefonnotiz zum Eilantrag und zur Mietlage

Gesprächsanlass

Frau Feldermann fragte nach dem heute eingereichten Antrag beim Sozialgericht Leipzig, Aktenzeichen S 7 AS 188/26 ER. Ihr wurde erläutert, dass zunächst eine Eingangsbestätigung oder gerichtliche Verfügung abzuwarten ist und ein konkreter Entscheidungszeitpunkt nicht zugesagt werden kann.

Mietrückstand

Der Vermieter Lars Günther habe um 13:48 Uhr angerufen und nach der restlichen Märzmiete gefragt. Eine Kündigung liege nicht vor. Frau Feldermann will ihm noch heute schriftlich mitteilen, dass ein gerichtliches Eilverfahren läuft, ohne einen Zahlungstermin zu versprechen. Sie reicht die Nachricht als Screenshot zur Akte.

Gesundheitliche Belastung

Nach dem Kanzleitermin am 17. Februar habe sie bis zum Folgetag überwiegend gelegen und nur mit Hilfe ihres Ehemanns gegessen. Während des Telefonats sprach sie langsam und bat nach etwa 15 Minuten um eine kurze Pause. Weitere Rückfragen werden deshalb gebündelt und möglichst schriftlich vorbereitet.

Vereinbarte Schritte

Die Kanzlei kontrolliert den gerichtlichen Eingang am 20. Februar. Frau Feldermann übersendet Vermieternachricht, Mietkonto und den letzten Kontoauszug. Ein weiterer Telefontermin wird nur bei neuem Bescheid oder gerichtlicher Verfügung vereinbart.

Vermerk diktiert um 16:44 Uhr; von Lea Krüger am 20. Februar 2026 um 08:18 Uhr zur elektronischen Akte genommen.

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Sozialrecht

Datei

Office-Dokument: 19d_telefonnotiz_akteneinsicht_2026-03-05.docx

Mandantin	Vivian Feldermann
Datum	5. März 2026, 14:30 bis 15:04 Uhr
Gespräch	Rechtsanwältin Marit Sonnemann
Dauer	34 Minuten einschließlich Pause

Telefonnotiz nach den Akteneinsichten

Ergebnisüberblick

Frau Feldermann wurde über die Einsichten bei der Rentenversicherung am 4. März und bei der BGW am 5. März informiert. In der BGW-Akte befindet sich eine protokollierte Aussage der Stationsleitung zu Belegung, Schutzmaterial und mehreren Infektionsfällen. Aussage, Dienstplan und Schlussfolgerung des Bescheids werden nun Blatt für Blatt abgeglichen; eine abschließende Bewertung wurde im Telefonat ausdrücklich nicht vorweggenommen.

Reaktion der Mandantin

Frau Feldermann fragte, ob frühere Kollegen bereits als Zeugen benannt werden müssten. Ihr wurde erläutert, dass zunächst Namen, Wahrnehmung und Erreichbarkeit getrennt zu sichern sind. Sie erinnert sich an Martin Rehbein aus dem Nachtdienst und an die damalige Hygienefachkraft Anne Grunert, kennt deren aktuelle Anschriften aber nicht.

Sozialgerichtliches Eilverfahren

Der Erörterungstermin ist auf den 12. März 2026 bestimmt. Frau Feldermann soll nach derzeitiger gerichtlicher Mitteilung telefonisch erreichbar sein; eine persönliche Anreise ist nicht angeordnet. Beginn, Einwahldaten und Vertretung werden nach Eingang der förmlichen Ladung bestätigt.

Prozesskostenhilfe und Unterlagen

Das unterschriebene Formular zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen ist am 4. März eingegangen. Es fehlen noch der Kontoauszug Februar und die Lohnabrechnung des Ehemanns für Februar. Frau Feldermann will beides bis 9. März per E-Mail übersenden.

Nächster Besprechungstermin: 17. März 2026, 11:00 Uhr, zunächst telefonisch. Vermerk unmittelbar nach Gesprächsschluss diktiert.

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Sozialrecht

Datei

Office-Dokument: 19g_kanzleivermerk_barrierearme_kommunikation_2026-03-05.docx

Mandantin	Vivian Feldermann
Vermerk	5. März 2026, 15:18 Uhr
Bearbeitung	Rechtsanwältin Marit Sonnemann
Geltung	Bis zur nächsten Mandantenbesprechung

Kanzleivermerk zur belastungsarmen Mandatskommunikation

Abstimmung mit der Mandantin

Frau Feldermann hat im Telefonat zugestimmt, dass nicht fristgebundene Rückfragen gesammelt und höchstens zweimal wöchentlich übermittelt werden. Bevorzugter Kanal ist E-Mail. Telefonate sollen vorher angekündigt und auf etwa 20 Minuten begrenzt werden; bei erkennbarer Erschöpfung wird eine Pause angeboten.

Interner Ablauf

Neue Bescheide, Ladungen und Fristsachen werden weiterhin am Eingangstag bearbeitet. In gewöhnlichen Sachstandsnachrichten stehen zuerst Anlass, erforderliche Handlung und Frist. Medizinische Details werden nur abgefragt, wenn sie für den nächsten Verfahrensschritt benötigt werden. Eine rechtliche Bewertung wird nicht als sichere Behörden- oder Gerichtsentscheidung dargestellt.

Dokumentation

Jeder telefonische Kontakt erhält eine eigene Notiz mit Datum, Beginn, Ende, Beteiligten und vereinbartem nächsten Schritt. E-Mails bleiben als EML-Dateien mit vollständigen Kopfzeilen in der Akte. Sammelprotokolle werden nicht fortgeführt, damit die Chronologie und der Zugang einzelner Mitteilungen nachvollziehbar bleiben.

Assistenzvermerk: Hinweis im Kanzleisystem durch Lea Krüger am 5. März 2026 um 15:31 Uhr gesetzt. Wiedervorlage zur Überprüfung am 17. März 2026.

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Sozialrecht

Datei

Office-Dokument: 20_strategie_priorisierung_verfahren.docx

Strategiepapier – Priorisierung und Verfahrensstrategie

Vertraulich – Nur zur internen Kanzleiverwendung

Erstellt: 07.03.2026

Erstellt durch: RA Sonnemann

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

I. Gesamtbewertung und Prioritäten

Die fünf parallelen Verfahren haben unterschiedliche Dringlichkeit und unterschiedliche Erfolgchancen. Nachfolgend eine Bewertungsmatrix:

Verfahren	Dringlichkeit	Erfolgsaussichten	Priorität
Eilantrag KdU (SG Leipzig)	KRITISCH	hoch (80 %)	1 – sofort
Widerspruch DRV EM-Rente	hoch	gut (65 %)	2 – bis 14.03.
Widerspruch BGW BK 3101	mittel	gut (60 %)	3 – bis März
Widerspruch/Klage LASOV GdB	mittel	sehr gut (75 %)	4 – bis April
Widerspruch Jobcenter SGB II	hoch	gut (70 %)	5 – parallel

II. Verfahren 1: Eilantrag KdU (S 7 AS 188/26 ER)

Status: Eingereicht 19.02.2026; Erörterungstermin 12.03.2026 SG Leipzig

Richter: Az. S 7 AS → 7. Kammer SG Leipzig (Vorsitz N.N., wird noch recherchiert)

Strategie:

- Eilbedürftigkeit (Anordnungsgrund): Sehr klar belegt durch Vermieter-Schreiben. Das SG wird zügig entscheiden.
- Anordnungsanspruch: Angemessenheits-Argumentation (Mietpreisspiegel 2024) + fehlerhafte Einkommensberechnung Jobcenter.
- Erwartetes Ergebnis: Das SG wird vorläufig die KdU auf 960,00 EUR anheben oder einen Betrag zwischen 780 und 960 EUR festsetzen. In jedem Fall Verbesserung der Situation.
- Falls das SG ablehnt: Sofortbeschwerde bei LSG Sachsen (Paragraf 173 SGG), Frist 1 Monat.

Nächste Schritte:

- [] Erörterungstermin 12.03.2026 wahrnehmen
- [] PKH-Antrag beim SG nachreichen (bis 10.03.2026)
- [] Mietpreisspiegel-Daten für Erörterungstermin aufbereiten

III. Verfahren 2: Widerspruch DRV Erwerbsminderungsrente

Status: Widerspruch eingereicht 12.03.2026; Akteneinsicht ausgewertet (Aktenstück 13)

Frist Widerspruchsentscheidung: keine gesetzliche Frist, aber Untätigkeitsklage nach 3 Monaten möglich

Strategie:

- Stärkster Angriffspunkt: Falschdiagnose im DRV-Gutachten (F43.2 statt F33.1/G93.3)
- Zweiter Angriffspunkt: Keine Auseinandersetzung mit PEM-Phänomen und POTS
- Dritter Angriffspunkt: Verstoß gegen Amtsermittlungsgrundsatz (Paragraf 20 SGB X)
- Beweisführung: Privatgutachten ME/CFS (Kosten über PKH oder VdK)
- Zeitlinie: Widerspruchsbescheid DRV erwartet in 3–6 Monaten (September–Dezember 2026). Dann Klage SG Leipzig (weitere Instanz).
- Rentenbeginn bei Erfolg: rückwirkend ab Antragstellung Januar 2024.

Finanzielle Bedeutung für Mandantin:

- Volle EM-Rente: ca. 1.180,00 EUR/Monat netto (geschätzt auf Basis Versicherungsverlauf 17,5 Jahre)
- Rückstand seit 01/2024: ca. 25 Monate $\times$ 1.180 EUR = ca. 29.500 EUR Nachzahlung

Nächste Schritte:

- ☐ Privatgutachten anfordern (Universitätsmedizin Berlin-Nord: Kosten klären, PKH prüfen)
- ☐ VdK Sachsen kontaktieren (Unterstützung ME/CFS-Verfahren)
- ☐ Widerspruchsbescheid DRV abwarten

IV. Verfahren 3: Widerspruch BK 3101 (BGW/BGW)

Status: Widerspruch eingereicht 26.02.2026; Akteneinsicht ausgewertet (Aktenstück 14)

Strategie:

- Zentrales Argument: Zeugenaussage Stationsleitung Wenzel (D13 in BGW-Akte) wurde vom BGW ignoriert
- Weiteres Argument: BGW-Beratungsgutachten veraltet (Oktober 2023, ohne S3-Leitlinie Post-COVID 2023)
- Stationsprotokolle UKL anfordern über BGW (Paragraf 193 SGB VII)
- Wichtig: BK-Anerkennung eröffnet Anspruch auf Verletztenrente (Paragraf 56 SGB VII), Heilbehandlung über BGW und ggf. Rente wegen Erwerbsminderung durch BGW — das ist ergänzend zur DRV-Rente.
- Zeitlinie: BK-Verfahren sind langsam (2–4 Jahre bis Klage). Kein Eilverfahren möglich.

Nächste Schritte:

- ☐ Anforderungsschreiben UKL für Stationsprotokolle vorbereiten (über BGW)
- ☐ Verdi/DBfK-Rechtsschutz prüfen (Musterverfahren BK 3101 Long-Covid)
- ☐ Kontakt Prof. Seifert für kausal-ärztliche Stellungnahme

V. Verfahren 4: GdB-Erhöhung (LASOV Sachsen)

Status: Widerspruch bereits eingereicht (10/2023), Übernahme durch Kanzlei 19.02.2026;
Widerspruchsbegründung übersandt

Strategie:

- Beste Erfolgsaussichten aller Verfahren (75 %): Fehler in Einzel-GdB-Bewertungen klar dokumentierbar
- Schwerbehindertenausweis (GdB $\geq$ 50) hat erhebliche praktische Bedeutung:
- Steuerliche Vorteile (Pauschbetrag Paragraph 33b EStG: 1.140–7.400 EUR p.a.)
- Erhöhter Kündigungsschutz (relevant für mögliche Weiterbeschäftigung Ehemann)
- Freifahrt ÖPNV mit Merkzeichen G + Freimarke
- Parkerleichterung (Merkzeichen aG, sofern einschlägig)
- Verfahrensvorbereitung: Neues Gutachten durch ME/CFS-Spezialist beantragen

Nächste Schritte:

- [] LASOV auf Bearbeitungsstand anfragen (Widerspruch seit 10/2023!)
- [] Antrag auf neues fachärztliches Gutachten beim LASOV stellen
- [] Ggf. Untätigkeitsklage vorbereiten (nach 3 Monaten seit Übernahme)

VI. Verfahren 5: SGB II / Jobcenter

Status: Widerspruch seit 11/2025; parallel Eilantrag SG Leipzig

Strategie:

- Einkommensberechnung korrigieren (Hauptargument)
- KdU-Angemessenheit (Hilfsargument, aber stark)
- Nach Eilantragsentscheidung: falls Jobcenter Widerspruch nicht bescheidet → Untätigkeitsklage

Nächste Schritte:

- [] Lohnabrechnung Marko Feldermann Januar + Februar 2026 anfordern (Aktualisierung)
- [] Jobcenter-Sachbearbeiterin Frau Winkler kontaktieren (telefonisch, informell)
- [] Ggf. Antrag Mehrbedarf Paragraph 21 Abs. 4 SGB II gesondert stellen

VII. PKH-Gesamtstrategie

Prozesskostenhilfe ist in allen gerichtlichen Verfahren beantragbar. Kanzlei hat PKH-Anträge vorbereitet für:

- SG-Eilverfahren KdU ✓ (eingereicht mit Eilantrag)
- Klageverfahren DRV EM-Rente (vorbereitend)

Einkommen Ehemann: 4.310 EUR brutto / ca. 2.883 EUR netto. Abzüglich Kinderfreibeträge und eigene Lebenshaltung ergibt sich ein PKH-relevantes bereinigtes Einkommen von voraussichtlich unter der PKH-Grenze. Berechnung in Aktenstück 21.

VIII. Interdependenzen der Verfahren

...

BK 3101 (BGW)

↓

EM-Rente DRV ← → GdB LASOV

↓ ↓

SGB II Jobcenter (Schwerbehinderung

↓ erhöht Bedarf /

KdU Eilantrag senkt Anrechnung)

...

- Eine BK-Anerkennung stärkt die EM-Rente-Argumentation (berufliche Ursächlichkeit)
- Ein höherer GdB (≥ 50) könnte SGB-II-Mehrbedarf auslösen und die Anrechnungsregeln verändern
- Die EM-Rente hätte bei Bewilligung direkte Auswirkung auf SGB-II-Anrechnung (Einkommen)
- Der Eilantrag KdU ist verfahrenstechnisch unabhängig, aber zeitlich prioritär

Vertraulich – Kanzlei Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Stand: 07.03.2026

Datei

Office-Dokument: 21_kostenrisiko_pkh_antrag.docx

Kostenrisiko und Prozesskostenhilfe-Berechnung

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

Erstellt: 17.02.2026

Erstellt durch: RA Sonnemann / Krüger (Berechnung)

I. Überblick Verfahrenskosten

A. Gerichtliche Verfahren (Sozialgerichtsbarkeit)

Im sozialgerichtlichen Verfahren (Paragrafen 183 ff. SGG) gilt für Versicherte, Rentenbezieher und ihre Hinterbliebenen in den meisten Verfahren **Gerichtskostenfreiheit** (Paragraf 183 SGG). Frau Feldermann als Versicherte ist gerichtskostenfrei.

Verfahren	Gericht	Gerichtskosten	Anwaltskosten (Schätzung)
Eilantrag KdU	SG Leipzig	0,00 EUR (Paragraf 183 SGG)	ca. 400–600 EUR
Widerspruchsverfahren DRV	DRV	0,00 EUR (Verwaltungsverfahren)	ca. 200–400 EUR
Widerspruchsverfahren BGW	BGW	0,00 EUR	ca. 200–400 EUR
Widerspruchsverfahren LASOV	LASOV	0,00 EUR	ca. 200–400 EUR
Widerspruchsverfahren Jobcenter	Jobcenter	0,00 EUR	ca. 200–400 EUR
Klageverfahren SG Leipzig (DRV)	SG Leipzig	0,00 EUR	ca. 800–1.200 EUR
Privatgutachten ME/CFS	extern	—	ca. 1.500–2.500 EUR
Gesamtschätzung		0,00 EUR	ca. 3.500–5.500 EUR

B. Prozesskostenhilfe (PKH)

Da das Sozialgerichtsverfahren für Versicherte gerichtskostenfrei ist, bezieht sich ein PKH-Antrag in der Sozialgerichtsbarkeit vorrangig auf die **Beiordnung eines Rechtsanwalts** (Paragraf 73a SGG i. V. m. Paragrafen 114 ff. ZPO). Wenn PKH bewilligt wird, werden die Anwaltskosten aus der Staatskasse übernommen.

II. PKH-Berechnung (Paragraf 115 ZPO)

A. Einnahmen der Bedarfsgemeinschaft

Einnahme	Betrag/Monat (brutto)
Einkommen Marko Feldermann (brutto)	4.310,00 EUR
Einkommen Vivian Feldermann	0,00 EUR
Kindergeld (2 Kinder)	500,00 EUR
Gesamt	4.810,00 EUR

B. Absetzbeträge Paragraf 115 ZPO

Absetzbetrag	Betrag/Monat
Einkommensteuer (lt. Lohnabrechnung 12/2025)	–608,00 EUR

Sozialversicherungsbeiträge	-819,00 EUR
Erwerbstätigenfreibetrag	-200,00 EUR
Wohnkosten (Paragraf 115 Abs. 1 Nr. 3 ZPO, tatsächliche Miete + Heizung)	-1.145,00 EUR
Freibetrag Partei (Paragraf 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 2b ZPO, 2026: 619 EUR)	-619,00 EUR
Freibetrag Ehegatte (Paragraf 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 2b ZPO, 2026: 619 EUR)	-619,00 EUR
Freibetrag Kind Liam (Paragraf 115 Abs. 1 Nr. 2c ZPO, 2026: 400 EUR)	-400,00 EUR
Freibetrag Kind Marlene (Paragraf 115 Abs. 1 Nr. 2c ZPO)	-400,00 EUR
Besondere Belastungen: Kfz-Kosten Arbeitsweg	-280,00 EUR
Kinderbetreuungskosten	-100,00 EUR
Krankheitsbedingte Mehraufwendungen Frau Feldermann (Medikamente, Fahrtkosten Arzt)	-150,00 EUR
Gesamtabzüge	-5.340,00 EUR

C. Ergebnis

	Betrag
Gesamteinnahmen	4.810,00 EUR
./. Gesamtabzüge	-5.340,00 EUR
Verbleibendes Einkommen (Paragraf 115 ZPO)	-530,00 EUR

Das verbleibende Einkommen unterschreitet die PKH-Grenze. Die Bedarfsgemeinschaft Feldermann ist für PKH-Zwecke mittellos. **PKH sollte ohne monatliche Raten bewilligt werden.**

III. PKH-Antrag – Verfahren

Eilantrag SG Leipzig (S 7 AS 188/26 ER)

PKH-Antrag wurde am 19.02.2026 zusammen mit dem Eilantrag eingereicht.

Beilagen zum PKH-Antrag:

- Ausgefüllte Erklärung über persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse (Formular PKH 1)
- Lohnabrechnung Marko Feldermann, Dezember 2025
- Kontoauszüge Bedarfsgemeinschaft (Dezember 2025 – Januar 2026)
- Mietvertrag (Unterkunftskosten)
- Belege Kinderbetreuung, Kfz-Kosten Arbeitsweg
- Nachweis krankheitsbedingte Mehrkosten (Apothekenbelege)

Klageverfahren DRV (vorbereitend)

PKH-Antrag wird bei Klageerhebung eingereicht. Unterlagen vorhanden.

IV. Alternativer Rechtsbeistand

Falls PKH abgelehnt wird oder nicht rechtzeitig bewilligt werden kann:

- **VdK Sachsen** (Verband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands): bietet kostenlose Rechtsberatung und Prozessbegleitung in sozialrechtlichen Verfahren für Mitglieder (Beitrag ca. 7 EUR/Monat) → Mitgliedschaft empfohlen.

- **DBfK** (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe): Möglicher Rechtsschutz für Mitglieder in BK-Verfahren.
- **Long Covid e. V. Deutschland**: Beratungsnetzwerk; ggf. Kontakt zu Anwälten mit Erfahrung in Long-Covid-BK-Verfahren.
- **Gebührenvereinbarung Kanzlei Sonnemann**: RA Sonnemann ist bereit, eine Stundensatz-Vereinbarung unterhalb des RVG zu prüfen, bis PKH bewilligt ist.

V. Kostenerstattung bei Erfolg

Im sozialgerichtlichen Verfahren trägt bei einer obsiegenden Partei der unterlegene Träger die außergerichtlichen Kosten (Paragraf 193 SGG). Bei Erfolg im:

- Eilantrag KdU: Jobcenter trägt RA-Kosten anteilig
- Klage DRV: DRV trägt RA-Kosten
- Klage LASOV: LASOV trägt RA-Kosten

Einzige Ausnahme: Widerspruchsverfahren — dort keine Kostenerstattung an den Bürger (Paragraf 63 Abs. 1 SGB X).

Erstellt: Kanzlei Sonnemann, 17.02.2026

Datei

Office-Dokument: 22_fristenuebersicht.docx

Fristenübersicht – Akte Feldermann

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

Stand: 10.03.2026

Verantwortlich: RA Sonnemann / Krüger (Fristenkontrolle)

Kritische Fristen (sofort / nächste Wochen)

Frist	Datum	Verfahren	Status	Anmerkung
Widerspruch BGW BK 3101	28.02.2026	BGW Hannover	Erledigt (26.02.2026)	Fax + Einschreiben
PKH-Antrag SG Leipzig	10.03.2026	Eilantrag KdU	Erledigt (19.02.2026, zusammen mit Eilantrag)	
Widerspruch DRV EM-Rente	14.03.2026	DRV Mitteldeutschland	Erledigt (12.03.2026)	Fax + Einschreiben
SG-Erörterungstermin	12.03.2026	SG Leipzig S 7 AS 188/26 ER	Heute	RA Sonnemann erscheint persönlich
Widerspruchsbegründung LASOV	15.03.2026 (eigene Frist)	LASOV Sachsen	Erledigt (19.02.2026)	Übernommen und begründet

Mittelfristige Fristen (nächste 3 Monate)

Frist	Datum (geschätzt)	Verfahren	Nächste Aktion
Widerspruchsbescheid BGW	ca. 05/2026	BGW Hannover	Eingang abwarten; dann Klagefrist 1 Monat
Widerspruchsbescheid DRV	ca. 09/2026	DRV Mitteldeutschland	Eingang abwarten; dann Klagefrist 1 Monat
Klage DRV, falls abgelehnt	1 Monat ab WB	SG Leipzig	Klageschrift vorbereiten
Klage BGW, falls abgelehnt	1 Monat ab WB	SG Leipzig	Klageschrift vorbereiten
Untätigkeitsklage Jobcenter	14.02.2026 + 3 Monate = 14.05.2026	SG Leipzig	Prüfen; ggf. Klageerhebung
Untätigkeitsklage LASOV	10.01.2026 + 3 Monate = 10.04.2026	SG Leipzig/LASOV	Nach Fristablauf prüfen
Kanzleitermin Mandantin	17.03.2026	alle Verfahren	Quartalsgespräch, alle Verfahren

Langfristige Fristen und Datenpunkte

Datum	Meilenstein
03.2026	Entscheidung SG-Eilantrag erwartet
04.2026	Evtl. Ergänzung LASOV-Widerspruch (neues Gutachten)
05.2026	Privatgutachten ME/CFS (Universitätsmedizin Berlin-Nord) bestellt/angefragt
06.2026	Nächste Vorstellung Universitätsmedizin Berlin-Nord (Prof. Seifert)
09.2026	Erwartete Widerspruchsentscheidung DRV
10.2026	Evtl. Klageschrift DRV SG Leipzig
2027	Hauptverhandlung(en) SG Leipzig
2028 (ggf.)	Berufung LSG Sachsen

Rechtsmittelfristen (zur Erinnerung)

Rechtsmittel	Frist	Rechtsgrundlage
Widerspruch gegen Verwaltungsakt	1 Monat ab Bekanntgabe	Paragraf 84 SGG

Klage nach Widerspruchsbescheid	1 Monat ab Bekanntgabe WB	Paragraf 87 Abs. 1 SGG
Untätigkeitsklage (Widerspruch)	nach 3 Monaten	Paragraf 88 Abs. 1 SGG
Untätigkeitsklage (Klage)	nach 6 Monaten	Paragraf 88 Abs. 2 SGG
Sofortbeschwerde (Eilantrag)	1 Monat ab Beschluss	Paragraf 173 SGG
Berufung (erstinstanzlich)	1 Monat ab Zustellung	Paragraf 151 SGG
Revision (nach LSG-Urteil)	1 Monat	Paragraf 164 SGG

Fristenkalender (Zusammenfassung Aktionen März–Mai 2026)

...

März 2026

12.03. Erörterungstermin SG Leipzig (Eilantrag KdU) → RA Sonnemann

12.03. Widerspruch DRV fristgemäß eingereicht

17.03. Kanzleitermin Feldermann (alle Verfahren)

April 2026

10.04. Prüfen: Untätigkeitsklage LASOV (falls kein WB)

15.04. Gutachten-Anfrage Universitätsmedizin Berlin-Nord (ME/CFS, Privatgutachten)

Mai 2026

14.05. Prüfen: Untätigkeitsklage Jobcenter (falls kein WB)

~~05.2026 Erwartete Widerspruchsentscheidung BGW~~

...

Fristen-Checkliste (wöchentliche Prüfung durch Krüger)

- [] Alle Eingangspost täglich sichten: Post von DRV, BGW, LASOV, Jobcenter, SG Leipzig
- [] Jede neue Frist sofort in Kanzlei-Fristenbuch eintragen
- [] Widerspruchsbescheide: 1-Monats-Klagefrist sofort notieren
- [] Nicht-Bescheide: nach 3 Monaten Untätigkeitsklage prüfen
- [] Fristen doppelt eintragen: primär (Frist) + Vorlaufmahnung (1 Woche vorher)

Stand: 10.03.2026 – RA Sonnemann

Nächste Aktualisierung: 17.03.2026 (Kanzleitermin)

Datei

Office-Dokument: docx/eilantrag_sg_leipzig_kdu_feldermann.docx

Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Rechtsanwältin Marit Sonnemann | Fachanwältin für Sozialrecht

Karl-Liebknecht-Straße 14 · 04107 Leipzig | Tel.: 0341 / 58 82 100

Sozialgericht
Bernhard-Göring-Straße
04107 Leipzig

Leipzig
1

Leipzig, den 19.02.2026

Az. SG Leipzig: S 7 AS 188/26 ER

Antragstellerin: Vivian Feldermann, Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig

Antragsgegner: Jobcenter Leipzig, Georgiring 3, 04103 Leipzig

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

– Übernahme der tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung (Paragraf 22 SGB II) –

Sehr geehrte Damen und Herren des Sozialgerichts Leipzig,

in Vollmacht meiner Mandantin, Frau Vivian Feldermann, beantrage ich,

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung nach Paragraf 86b Abs. 2 SGG zu verpflichten, der Antragstellerin ab sofort vorläufig die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß Paragraf 22 SGB II in Höhe von 960,00 EUR (Kaltmiete) zuzüglich Heizkosten von 185,00 EUR monatlich zu gewähren, bis zur abschließenden Entscheidung in der Hauptsache.

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin lebt mit ihrem Ehemann Marko Feldermann und zwei Kindern (Liam, 11 J.; Marlene, 8 J.) in Leipzig-Connewitz (Bornaische Straße 78). Die monatliche Kaltmiete beträgt 960,00 EUR, Heizkosten 185,00 EUR. Die Antragstellerin ist aufgrund einer schweren Long-Covid-Erkrankung mit ME/CFS vollständig erwerbsunfähig. Der Antragsgegner hat mit Bescheid vom 14.11.2025 die KdU auf 780,00 EUR begrenzt. Infolge von Mietrückständen (2 × 180,00 EUR = 360,00 EUR) hat der Vermieter mit Schreiben vom 28.01.2026 eine Räumungsklage angedroht und eine Frist bis 28.02.2026 gesetzt.

II. Anordnungsgrund – Eilbedürftigkeit

Der Anordnungsgrund ergibt sich aus der unmittelbar drohenden Räumungsklage. Der Wohnungsverlust für eine Familie mit einer schwerkranken Mutter (ME/CFS, POTS) und zwei minderjährigen Schulkindern stellt einen irreversiblen Schaden dar, der durch eine spätere Hauptsacheentscheidung nicht mehr geheilt werden kann. Das BSG hat in ständiger

Rechtsprechung (BSG, Beschl. v. 07.11.2011 – B 4 AS 156/11 R) anerkannt, dass bei konkret drohendem Wohnungsverlust ein Anordnungsgrund im SGB-II-Bereich gegeben ist.

III. Anordnungsanspruch

Ein Anordnungsanspruch ist glaubhaft gemacht. Die Kaltmiete von 960,00 EUR (= 12,00 EUR/m² bei 80 m²) ist für eine 4-Zimmer-Wohnung in Leipzig-Connewitz nach dem Mietpreisspiegel Leipzig 2024 angemessen. Das Jobcenter Leipzig hat keine nach den Anforderungen des BSG (schlüssiges Konzept; BSG, Urt. v. 22.09.2009 – B 4 AS 18/09 R) leitliniengerecht ermittelte Angemessenheitsgrenze vorgelegt. Der pauschale Richtlinienwert von 780,00 EUR liegt deutlich unter dem Wohnungsmarkt in Connewitz (10,80–14,20 EUR/m² laut Mietpreisspiegel 2024) und ist rechtlich nicht tragfähig.

Hinzu kommt, dass das Jobcenter keine ordnungsgemäße Kostensenkungsaufforderung mit angemessener Frist (mindestens 6 Monate) erlassen hat. Die sofortige KdU-Kürzung ab 01.01.2026 widerspricht Paragraph 22 Abs. 1 S. 3 SGB II.

IV. Prozesskostenhilfe

Ich beantrage Prozesskostenhilfe für das Eilverfahren und Beiordnung von RA Sonnemann. Das bereinigte Haushaltseinkommen unterschreitet die PKH-Grenze (Paragraph 115 ZPO). Die PKH-Erklärung liegt bei.

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin | Fachanwältin für Sozialrecht

Anlagen: Eidesstattl. Erklärung Feldermann, Vermieterschreiben 28.01.2026, Befund Universitätsmedizin Berlin-Nord 11/2025, Bescheid Jobcenter 14.11.2025, Mietvertrag, Mietpreisspiegel Leipzig 2024 (Auszug), Lohnabrechnung Ehemann 12/2025, PKH-Antrag

Datei

Office-Dokument: docx/widerspruch_bgw_bk3101_feldermann.docx

Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Rechtsanwältin Marit Sonnemann | Fachanwältin für Sozialrecht

Karl-Liebknecht-Straße 14 · 04107 Leipzig | Tel.: 0341 / 58 82 100

Berufsgenossenschaft Bezirksverwaltung Lützner 04177 Leipzig	für	Gesundheitsdienst Straße	und	Wohlfahrtspflege 105	(BGW) Leipzig
---	-----	---------------------------------	-----	-----------------------------	------------------

Leipzig, den 26.02.2026

Aktenzeichen BGW: BK 3101 / 261/26

Mandantin: Vivian Feldermann, geb. 03.09.1984, Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig

**Widerspruch gegen Bescheid vom 28.01.2026
– Ablehnung Berufskrankheit Nr. 3101 (Anlage 1 BKV) –**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vollmacht meiner Mandantin Frau Vivian Feldermann erhebe ich gegen den Bescheid der BGW vom 28.01.2026 (Az. BK 3101 / 261/26) fristgemäß

Widerspruch

und beantrage, den Bescheid vom 28.01.2026 aufzuheben und die Erkrankung meiner Mandantin (Post-Covid-Syndrom mit ME/CFS) als Berufskrankheit gemäß Nr. 3101 der Anlage 1 zur BKV anzuerkennen sowie die sich daraus ergebenden Leistungen (insbesondere Verletztenrente nach Paragraph 56 SGB VII) zu gewähren.

I. Sachverhalt

Frau Vivian Feldermann war bis November 2021 als Gesundheits- und Krankenpflegerin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) tätig. Ab 01.11.2021 wurde sie auf der Covid-Isolierstation eingesetzt. Am 14.11.2021 wurde ein PCR-Test positiv auf SARS-CoV-2 befundet. Seitdem leidet sie an einem schweren Post-Covid-Syndrom mit den Diagnosen: Post-Covid-Syndrom (U09.9), ME/CFS schwer (G93.3, nach Canadian Consensus Criteria, Prof. Dr. Seifert, Universitätsmedizin Berlin-Nord Berlin), POTS (G90.3) und rezidivierende depressive Störung (F33.1).

II. Berufliche Exposition (Paragraf 9 Abs. 1 SGB VII i. V. m. Nr. 3101 Anlage 1 BKV)

Die BGW bestreitet im angefochtenen Bescheid die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer beruflichen Infektion. Diese Einschätzung ist unzutreffend. Der PCR-Positivbefund fiel genau in die Phase des Covid-Stationseinsatzes (01.–14.11.2021), innerhalb der typischen Inkubationszeit von SARS-CoV-2. Eine Privatexposition ist nicht überwiegend wahrscheinlich: Der Ehemann war im Homeoffice tätig; die Kinder wurden nicht positiv getestet.

Entscheidend: Die BGW hat in ihrer eigenen Ermittlungsakte (Abschnitt D, Bl. 13) eine Zeugenaussage der Stationsleitung Covid-A (Frau Petra Wenzel) dokumentiert, die bestätigt: ‚Es gab Phasen, in denen FFP2-Masken knapp waren und wir auf OP-Masken zurückgegriffen haben.‘ Diese Aussage findet sich im Ablehnungsbescheid mit keinem Wort. Dies stellt einen gravierenden Begründungsfehler dar (Paragraf 35 SGB X).

III. Haftungsausfüllende Kausalität

Die BGW zweifelt am Kausalzusammenhang zwischen SARS-CoV-2-Infektion und Post-Covid/ME/CFS. Diese Zweifel sind seit Erscheinen der S3-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID (AWMF 020-027, Dezember 2023) nicht mehr haltbar. Die Leitlinie erkennt Post-Covid als eigenständiges Krankheitsbild nach nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion an. Das BGW-Beratungsgutachten (Dr. Böhme, Oktober 2023) ist veraltet und berücksichtigt diese Leitlinie nicht.

IV. Verfahrensmangel und Beweisangebote

Ich beantrage: (1) Vollständige Akteneinsicht nach Paragraf 25 SGB X. (2) Einholung neuer Stationsprotokolle UKL (November 2021) nach Paragraf 193 SGB VII. (3) Zeugenbefragung: Frau Petra Wenzel (Stationsleitung Covid-A, UKL), Herr Klaus Dittmann (Betriebsratsvorsitzender UKL). (4) Einholung eines aktuellen arbeitsmedizinischen Gutachtens unter Berücksichtigung der S3-Leitlinie Post-COVID 2023.

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann
Rechtsanwältin | Fachanwältin für Sozialrecht

Anlagen: Vollmacht, Befund Prof. Seifert (11/2025), Befund Dr. Märker (01/2026), PCR-Testergebnis (14.11.2021), Schichtplan UKL November 2021, S3-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID (Auszug, AWMF 020-027, 2023)

Datei

Office-Dokument: docx/widerspruch_drv_em_rente_feldermann.docx

Sonnemann Sozialrecht Leipzig

Rechtsanwältin Marit Sonnemann | Fachanwältin für Sozialrecht

Karl-Liebknecht-Straße 14 · 04107 Leipzig

Tel.: 0341 / 58 82 100 · Fax: 0341 / 58 82 101 · kanzlei@sonnemann-sozialrecht.de

Deutsche
Georg-Schumann-Straße
04155 Leipzig

Rentenversicherung

Mitteldeutschland
146

Leipzig, den 12.03.2026

Aktenzeichen DRV: xx 060379 41 W 077

Versicherungsnummer: 41 060379 V 084

Mandantin: Vivian Feldermann, geb. 03.09.1984, Bornaische Straße 78, 04277 Leipzig

Widerspruch gegen Bescheid vom 14.02.2026 – Ablehnung Rente wegen Erwerbsminderung –

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vollmacht meiner Mandantin Frau Vivian Feldermann erhebe ich gegen den Bescheid der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland vom 14.02.2026 (Az. xx 060379 41 W 077) fristgemäß

Widerspruch

und beantrage, den Bescheid vom 14.02.2026 aufzuheben und meiner Mandantin rückwirkend ab dem 01.02.2024 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung gemäß Paragraph 43 Abs. 2 SGB VI zu bewilligen. Hilfsweise beantrage ich die Bewilligung einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung.

I. Sachverhalt

Frau Vivian Feldermann, geb. 03.09.1984, war bis November 2021 als Gesundheits- und Krankenpflegerin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) tätig. Im November 2021 erkrankte sie während eines beruflichen Einsatzes auf der Covid-Isolierstation schwer an SARS-CoV-2. Seitdem ist sie dauerhaft vollständig arbeitsunfähig und leidet an einem schweren Post-Covid-Syndrom (Post-Exertional Malaise, ME/CFS nach Canadian Consensus Criteria, POTS – posturales Tachykardiesyndrom – sowie psychiatrische Komorbidität F33.1, diagnostiziert durch Prof. Dr. Maja Seifert, Universitätsmedizin Berlin-Nord Berlin und das Klinikum am Auenwald Leipzig).

Das durchschnittliche tägliche Aktivitätsfenster meiner Mandantin beträgt laut sechsmonatigem Symptومتagebuch (August 2025 – Januar 2026) 11 Minuten. An 58 % aller Tage ist Frau Feldermann vollständig bettlägerig oder ans Sofa gebunden.

II. Fehlerhafte medizinische Grundlage

Das DRV-Gutachten (Dr. med. Volker Härtung, Arbeitsmedizin/Sozialmedizin, November 2025) stellt als Hauptdiagnose eine Anpassungsstörung (F43.2) fest. Diese Diagnose ist per definitionem falsch: eine Anpassungsstörung klingt nach den ICD-10-Kriterien innerhalb von 6 Monaten nach Wegfall des Stressors ab. Die Symptome meiner Mandantin bestehen seit über vier Jahren unverändert fort.

Das Sächsische Krankenhaus für Psychiatrie Leipzig (SKH) hat nach stationärer Behandlung (September bis November 2024) die Diagnose F33.1 (rezidivierende depressive Störung, mittelgradige Episode) gestellt – eine wesentlich schwerere Erkrankung. Das DRV-Gutachten setzt sich mit dieser Fachdiagnose nicht auseinander. Gleiches gilt für die ME/CFS-Diagnose der Universitätsmedizin Berlin-Nord (Prof. Dr. Seifert) und den objektivierten POTS-Befund (positiver Kipptisch-Test, Kardiologie UKL, April 2022).

III. Rechtliche Würdigung

Gemäß Paragraph 43 Abs. 2 SGB VI sind Versicherte voll erwerbsgemindert, wenn sie wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Das BSG (Urt. v. 12.12.2011 – B 13 R 21/10 R) hat klargestellt, dass eine verlässliche, wettbewerbsfähige Arbeitstätigkeit nicht gegeben ist, wenn das Leistungsvermögen so schwankend oder begrenzt ist, dass kein Arbeitgeber die Versicherte einstellen würde.

Post-Exertional Malaise (PEM) – das Kernsymptom von ME/CFS – ist mit einem sechsständigen Restleistungsvermögen unvereinbar, da jede Aktivität über das individuelle Energiebudget hinaus zu mehrtägigen Zustandsverschlechterungen führt. Ich verweise auf die S3-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID (AWMF-Register 020-027, Dezember 2023) sowie auf die ME/CFS-Leitlinien der Universitätsmedizin Berlin-Nord.

IV. Beweisangebote

Ich beantrage: (1) Vollständige Akteneinsicht in die Rentenakte einschließlich des vollständigen Gutachtens Dr. Härtung. (2) Einholung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens durch einen auf Post-Covid/ME/CFS spezialisierten Facharzt. (3) Beiziehung der beigefügten Befundberichte (Prof. Dr. Seifert, Universitätsmedizin Berlin-Nord, 11/2025; Klinikum am Auenwald Leipzig, 02/2026; Dr. Märker, Hausarzt, 01/2026).

Mit freundlichen Grüßen

Marit Sonnemann

Rechtsanwältin | Fachanwältin für Sozialrecht

Anlagen: Vollmacht, Befundberichte (Universitätsmedizin Berlin-Nord, SKH, Hausarzt), PEM-Tagebuch-Auszug (6 Monate)